

Cochlear™ Aktuel Magazin

Salyangoz

İlkbahar / Yaz 2012

www.cochlear.com.tr



Cochlear™ Nucleus®
Sistemine Geçiş



Baha® 3 Sistemi ile
Seslerin Keyfini çıkartın



09

SoruYorum

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Esra Yücel koklear implant, işitme kaybı ve işitme kayıplı çocuklara yaklaşımlar konusunda sizin sorularınızı yanıtlıyor.



46-47



İÇİNDEKİLER

05 Katkıda Bulunanlar

06-07 Nasıl İşitiriz?
Cochlear İşitme Çözümleri

09 Soru Yorum

10-11 Biliyor musunuz?

12-13 Kısa Kısa

14-15 Servis Güncel
Ankara'da yeni ofisimizdeyiz

16 Dikkat!
Dry & Store yazın vazgeçilmezi



Ankara'da Yeni ofisimizdeyiz

14

2012 yılı Mart ayı itibariyle faaliyete geçen yeni ofisimizde; çocuk oyun alanı ve bekleme salonu ile kullanıcıların daha rahat hizmet alması hedeflendi.



Bir an kendimi
kuş gibi hafif hissettim

48-49

24 yaşında genç bir mühendis adayı ve 8 yıldır Baha® kullanıyor. Yaşitları gibi dolu dolu bir hayatı var; dans ediyor, Almanca konuşuyor hatta çokça seyahat edip yurt dışında bir iş deneyimi bile edinmiş. 8 yıldır Baha kullanan Zafer Kitay'la kendi hikâyesini konuştuk...



Tanıyalım

40-41

Mutluyum Özel Eğitim Merkezin'de
Güler Yüzlü Titiz Eğitim, Ailelerin de Yüzünü Güldürüyor

Baha® Sistemi

22-25

Baha® 3 Sistemi ile seslerin keyfini çıkarın...



18-19 Yakın Çekim
Doç. Dr. Gonca SENNAROĞLU

20-21 Bilimsel Bakış
Çocuklarda işitme kaybı ve odyolojik
değerlendirmenin önemi

22-25 Baha® Sistemi
Baha® 3 Sistemi ile seslerin keyfini
çıkarm...

26-27 Baha® Sistemi
Baha® ile daha iyi işitme

28-29 Tanıyalım
Şan(s)lırfa'da Yekta

30-31 Bilimsel Bakış
İşitme kayıplı çocuklarda dinlemenin önemi

32-33 Benim Hikayem
Yıllardan beri gidemediğim sinemaya, tiyatroya
gidebiliyorum artık...

34-37 Yakın Çekim
İşinizi ne kadar iyi yaparsanız, o kadar iyi
anılırsınız

38-39 Bilimsel Bakış
İşitme Kaybının Aile-Çocuk Etkileşimi
Üzerindeki Etkisi

40-41 Tanıyalım
Mutluyum Özel Eğitim Merkezin'de
Güler Yüzlü Titiz Eğitim, Ailelerin de Yüzünü
Güldürüyor



42-43 Benim Hikayem
Kulaklarım kulaklıklarım

44-45 Bilimsel Bakış
Koklear implant öncesi ailenin değerlendirilmesi

46-47 Kulak Verin
Bugün, geleceğiniz için bir sonraki adımı atın!

48-49 Benim Hikayem
Bir an kendimi kuş gibi hafif hissettim

50-51 Tanıyalım
'Eğitim okulda başlar, evde biter' düşüncesinden uzak bir kurum özel Antalya melekler özel eğitim okulu...

52-53 Aktiviteler

54 Blog not

Salyangoz

Cochlear Tıbbi Cihazlar ve Sağ. Hizm. Ltd. Şti. adına
sorumlu müdür Nalan Ataç

Genel yayın yönetmeni ve yazı işleri müdürü
Çağlar Ballı

Yayın koordinatörü ve düzeltmen
Meryem Topcu

Yazarlar
Medine Altındağ
Gizem Babaoğlu
Ahmet Hacıoğlu
Fikret Tezal
Merve Özbal

Katkıda bulunanlar
Dr. Uzm. Ody. Şenay Altınyay
Doç. Dr. Günay Kırkım
Uzm. Ody. Rasim Şahin
Dr. Uzm. Ody. Zerrin Turan

Tasarım
Bart Reklam Ajansı
Uğur Ateş

Baskı
Stil Matbaacılık A.Ş.
İbrahimkaraoğlu cad. yayıncılar sok
Stil binası seyrantepe / 4.levant
Tel : 0212 281 92 81

Adres
Cochlear Tıbbi cihazlar ve sağ. Hizm. Ltd. Şti.
Çubuklu Mah. Boğaziçi Plaza
No: 6/1 Kavacık, Beykoz -İstanbul
info-tr@cochlear.com

Dergideki yazıların sorumlulukları yazarlarına aittir ve
ancak izin alınarak alıntı yapılabilir.
Cochlear Tıbbi Cihazlar firmasının ücretsiz yayınıdır.

Basım Tarihi
20 / 06 / 2012

Hoş geldiniz,

İlginiz için teşekkürler,

Cochlear Salyangoz'un ilk sayısı sizlerin ilgisi ve desteği ile Türkiye'nin her yerinde beş binden fazla kişiye ulaştı. Öncelikle bizlere verdiğiniz bu destek için hepimize teşekkür etmek istiyoruz.

Cochlear™ firması ile koklear implant ve Baha® kullanıcıları arasındaki bağı kuvvetlendirecek bir köprü olan bu dergide, sizlerden aldığımız geribildirimler doğrultusunda konularımızı genişletmeye devam ediyor olacağız. Bir önceki sayımızdan farklı olarak, bu sayımızda sizlerden sıklıkla gelen sorulara profesyonel yanıtlar olarak sizlere işitmeye giden yolculuğunuzda doğru bir yol göstermeyi amaçladık.

1981 yılında kurulan Cochlear™, implante edilebilen işitme çözümlerinde dünya lideridir. Şirketimiz, duyma mucizesini dünyanın her yerindeki insanlara ulaştırmayı amaç edinmiştir. Bugün 100'den fazla ülkede 200.000'den fazla kişi, işitme sistemlerimizden birinin yardımıyla aileleri, arkadaşları ve çevreleriyle yeniden iletişim kurmaya başlamıştır. Firmamız, Nucleus® koklear implantları ve Baha kemik iletimli implantlarıyla farklı tipteki işitme kayıplarına sahip kişiler için çözümler sunmaktadır

Cochlear™ Mayıs 2008 yılından beri Türkiye'de açtığı ofisler ile, Türkiye'deki kullanıcılarına direkt hizmet vermeye başlamıştır. Ofislerimiz, müşteri hizmetleri ve verdiğimiz hizmetler ile ilgili detaylı bilgiyi dergimizin bu sayısında bulabilirsiniz. Cochlear, kullanıcı memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, koklear implant firmaları içinde tek ücretsiz 0800 261 71 81 kullanıcı yardım hattı ve zengin içerikli internet sitesi ile, lider hizmet anlayışını Türkiye'deki kullanıcılarına sunmuştur.

Bugün, Cochlear'ın yaşam boyu müşteri desteği sözüne tereddütsüz güvenerek dünyada her on koklear implant kullanıcısından yedisi Nucleus Koklear implant sistemini tercih etmektedir.– Hear now. And always.

Bu sayımızda, Hacettepe Üniversitesi'nin en sevilen hocalarından Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu ve Çapa Tıp Fakültesi KBB bölümünün duayen hocalarından Prof. Dr. Yahya Güldiken ile yapılan röportajları, çeşitli rehabilitasyon merkezlerinin çalışmalarını ve ürünlerimiz ile ilgili son gelişmeleri bulabilirsiniz. Koklear implant ya da Baha cihazlarının sağlıklı ve uzun süreli kullanımına ilişkin ip uçlarını yetkili müşteri hizmetleri uzmanlarımızın kaleminden öğrenebilir ve koklear implant ve Baha kullanıcılarımız ile tanışma fırsatı yakalayabilirsiniz. Onların işitmeye giden yoldaki hikâyelerini dinlerken eminiz siz de kendinizden bir şeyler bulacaksınız.



Nalan Ataç
Cochlear Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü



Doç.Dr. Günay KIRKIM

1976- 1981 yılları arasında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini bitirdikten sonra, E.Ü. İzmir Tıp Fakültesi KBB AD Odyoloji Ünitesi'nde göreve başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak kurulan, yine aynı kurumunda yüksek lisans eğitimini Odyoloji alanında tamamladı. Yüksek lisans tezini "İletim Tipi İşitme Kaybı olan Erişkin ve Çocuklarda Empedansmetrenin değeri" konusunda yaptı. 1998-2003 yılları arasında Marmara Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamladı. Doktora

tezini "Presbiakuzide Orta Latans İşitsel Uyarılmış Potansiyeller" konusunda yaptı. 2010 yılında Odyoloji Bilim alanında Doçent ünvanı aldı. Evli ve 2 erkek çocuk annesi olan Günay Kırkım halen D.E.Ü. Hastanesi KBB AD İşitme Konuşma Denge Ünitesi'nde eğitim ve klinik çalışmalarını sürdürmektedir.



Uzm.Ody. Rasim ŞAHİN

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği Ana Bilim dalında tamamladıktan sonra Yüksek lisans eğitimini Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kulak Burun Boğaz, Odyoloji programında tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini 'Koklear İmplant olan Hastaların Rezidüel İşitmelerinin Değerlendirilmesi' konusunda yapmıştır. 2000 yılından bu yana koklear implantlı hastaların değerlendirilmesi, implant sonrası eğitim-

leri ve cihazların programlamalarıyla yakından ilgilenen Rasim Bey halen Çukurova Üniversitesi Halil Avcı Duyma Engelliler Merkezinde hem klinik odyoloji hem işitme engelli çocukların eğitimi birimlerinde çalışmalarına devam etmektedir.



Dr. Uzm. Ody.
Zerrin TURAN

1987'den beri Eskişehir İÇEM'de odyoloji bölüm sorumlusu olarak çalışıyor. 1999'da doktorasını tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde aile eğitimi, işitme cihazları, koklear implant konularında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde dersler de vermeye

başladı. Zerrin Turan, işitme testleri, cihazlandırma, implant değerlendirme ve programlama, aile eğitimi ve aile eğitimi yetiştirme alanlarında çalışıyor.



Uzm. Ody.
Şenay ALTINYAY

Eğitim hayatına 1992 yılında bitirdiği Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Odyometri Bölümü ile başlamış ve 1996 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü "Zihinsel Engelliler Öğretmenliği" bölümünü bitirerek devam etmiştir. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri, Odyoloji Konuşma ve Ses Bozuklukları Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. 2009 yılında başlamış olduğu Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Özel Eğitim Doktora programına devam etmektedir. 1997-2001 yılları arasında

Ankara'da özel işitme konuşma eğitim rehabilitasyon merkezinde çalışmış olup, 2001 yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi KBB Ana Bilim dalı Odyoloji Bilim dalında "Eğitim Odyolojisi" biriminde çalışmaya devam etmektedir. İşitsel-sözel terapi, erken çocukluk dönemi işitme kayıplı çocuklar, koklear implantlı bireyler, işitsel nöropati konularıyla ilgilenen Şenay Altınyay aynı zamanda 2011 yılında Waaren Estabrooks ile AVT programını tamamlamıştır.



Cochlear™

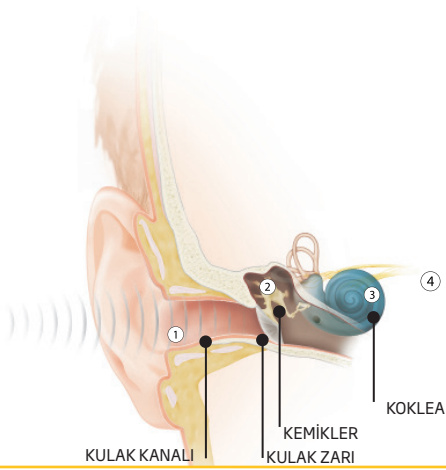
İşitme Çözümleri

Bir bakışta işitme çözümleri



En iyi işitme performansını sağlar

Nasıl İşitiriz?



Ses doğal olarak hava ve kemik iletimi yoluyla algılanır.

1. Ses dalgaları kulak kanalı içinde ilerler ve kulak zarına çarpar.
2. Bu ses dalgaları kulak zarını ve orta kulakta bulunan üç kemiği titreştirir.
3. Oluşan titreşimler – koklea olarak bilinen – iç kulaktaki sıvılara gönderilir ve kokleadaki tüylü kılsal hücreleri hareket ettirir.
4. Tüylü hücrelerin hareketi sinirsel uyarım oluşturur ve oluşan uyarımlar işitme sinirinden sesin algılandığı yer olan beyne gönderilir.

Cochlear™ Nucleus® Sistemi ile İşitme



Cochlear Nucleus Sistemi hem harici hem de dahili bileşenlere sahiptir:

- Bobin **B** içeren ses işlemcisi **A** kulağın arkasına takılır.
 - İmplant **C** kulağın arkasında, derinin hemen altına yerleştirilir.
1. Ses işlemcisi çevresel sesleri toplar ve dijital kodlara dönüştürür.
 2. Ses işlemcisi dijital olarak kodlanmış sesi bobin üzerinden derinin hemen altında bulunan implanta iletir.
 3. İmplant dijital olarak kodlanmış sesi elektrik sinyallerine dönüştürür ve koklea içinde bulunan elektrot dizinine gönderir.
 4. İmplant üzerinde bulunan elektrotlar kokleada bulunan işitme siniri liflerini uyarır ve böylece ses sinyalleri beyne aktarılır – rakışitme duyusu oluşturulur.
 5. İşitme durumunuzu remote assistant yoluyla veya doğrudan ses işlemcisi üzerinden yönetebilirsiniz.



*Kombine performansın sunduğu
mükemmellik*

Cochlear™ Baha® 3 Sistemi ile işitme



İşitme deneyiminiz tamamlanıyor

Cochlear™ Hybrid™ Sistemi ile İşitme



Cochlear Baha® 3 Sistemi üç parçadan oluşur:

- Ses işlemcisi.
- Bağlantı abutment.
- Kulak arkasındaki kemiğe yerleştirilen titanyum implant.

1. Ses işlemcisi sesi algılar, temizler,
2. Abutment yükseltile titreşimleri alır ve kemiğe entegre edilmiş titanyum implanta aktarır.
3. İmplant, ses kemik iletiminden yararlanarak ses titreşimlerini doğrudan kokleaya aktarır.



Cochlear Hybrid Sistemi hem harici hem de dahili bileşenlere sahiptir:

- Bobin (B) içeren ses işlemcisi (A) kulağın arkasına takılır.
- Akustik bileşen (C) kulak kanalına takılır.
- Koklear implant (D) kulağın arkasında, derinin hemen altına yerleştirilir.

1. Harici ses işlemcisi sesi yakalar, yüksek frekanslara ve alçak frekanslara ayırır.
- 2a. Ses işlemcisi yüksek frekansları implanta gönderilen dijital sinyaller biçiminde kodlar.
- 2b. Ses işlemcisi akustik bileşene gönderilen alçak frekansları yükseltir.
3. İşitme sinirinin elektriksel ve akustik uyarıma verdiği cevap, tek bir ses algısına dönüştürülmek üzere beyine gönderilir.

Telefon kullanımı kolaylaştırıldı

Yeni kurulan Telekomünikasyon Kurumu'nun (TKTK) düzenlediği eğitimlerle vatandaşların telefon kullanma becerileri artırıldı.



TKTK'nın düzenlediği eğitimler, vatandaşların telefon kullanma becerilerini artırarak, teknolojiyi daha etkin kullanmalarını amaçlıyor.

Eğitimler, vatandaşların telefon kullanma becerilerini artırarak, teknolojiyi daha etkin kullanmalarını amaçlıyor. Eğitimler, vatandaşların telefon kullanma becerilerini artırarak, teknolojiyi daha etkin kullanmalarını amaçlıyor.

TKTK'nın düzenlediği eğitimler, vatandaşların telefon kullanma becerilerini artırarak, teknolojiyi daha etkin kullanmalarını amaçlıyor.

TKTK'nın düzenlediği eğitimler, vatandaşların telefon kullanma becerilerini artırarak, teknolojiyi daha etkin kullanmalarını amaçlıyor.

TKTK'nın düzenlediği eğitimler, vatandaşların telefon kullanma becerilerini artırarak, teknolojiyi daha etkin kullanmalarını amaçlıyor.

TKTK'nın düzenlediği eğitimler, vatandaşların telefon kullanma becerilerini artırarak, teknolojiyi daha etkin kullanmalarını amaçlıyor.



Bir sorum var?



Doç. Dr. Esra YÜCEL

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Esra Yücel koklear implant, işitme kaybı ve işitme kayıplı çocuklara yaklaşımlar konusunda sizin sorularınızı yanıtlıyor.



Çocuğum, Cochlear implant kullanmasına rağmen, işaret dili ile konuşuyor. Bu konudaki önerileriniz nelerdir?

Koklear implant kullanıcısı olan çocuklar diğer işitme engelli çocuklar gibi bireysel farklılıklar gösterir. Bu bireysel farklılıklar seçilecek uygun eğitim programının tipini ve yoğunluğunu belirler. Bu etkin faktörler çocuğun hikayesi, yaşı, dili kullanım becerisi, iletişim şekli, sosyal/duygusal gelişim, aile ve kültürel çevreden oluşur. Tüm bu faktörler koklear implant sonrası beklentilerin ve seçilecek eğitim ortamının belirleyicisidir.

Koklear implant kullanıcısı bir çocuk için en uygun program; çocuğun eğitimsel gelişimini etkileyen tüm faktörleri göz önünde bulundurarak, çocuğun ihtiyaçlarına cevap verebilen ve çocuğu sadece implant kullanımına göre değil bir bütün olarak ele alan bir yapıda olmalıdır. Bu yapı hem görsel ipuçları (dudak okuma, işaret dili) hem de konuşma dilinin gelişimini sağlayan nitelikte olabilir. Ancak, koklear implant kullanıcısı olan bir çocuğun kesinlikle işitmesini sürekli olarak kullanacağı ve konuşma dilini geliştireceği uygun bir eğitim programına dahil edilmesi koklear implanttan sağlayacağı yararı destekler.

Koklear implantlar tüm küçük yaş grubundaki çocuklarda başarı sağlar mı?

Yapılan çalışmalar ve deneyimlerimiz;

- Küçük çocukların işitme, konuşma, dil gelişimi ve sosyal öğrenme açısından koklear implant sonrası belirgin gelişme gösterdiklerini,
- Bireysel farklılıklar nedeni ile elde edilen sonuçların farklı olduğunu ve eğitim desteği ihtiyacının buna göre değişeceğini,
- Üç yaştan önce ameliyat olanların daha ileri yaşta ameliyat olanlara göre koklear implanttan daha fazla yarar sağladığı gözlemlenmiştir.

Hersayım zedabuku edenyantlayacaım zsoruların zisinbizeaıdaki iletim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

Sorularınız için,
Mail adresi : mtopcu@cochlear.com
Yazışma adresi : Cochlear - Türkiye, Bogazici Cad.
No:6/1 34805 Kavacık, İstanbul

Tüm işitme engelli çocuklar koklear implant için uygun mudur?

Hayır değildir. Tek taraflı veya "ileri ve çok ileri" dereceden daha az seviyede işitme kaybı bulunan çocuklar implant adayı değildir. Konuşma ve dil gelişimi açısından işitme cihazından yeterince yarar sağlayamayan çocuklar potansiyel aday grubunu oluşturur. Bu çocukların implant ihtiyaçlarının belirlenmesi için işitsel algı ve dil gelişim değerlendirmeleri yapılmalıdır.

Koklear implant aracılığı ile gelen sesler neye benzer?

Koklear implantla duyulan sesler doğal sesler değildir. İşitme cihazı ile duyduğumuz seslerden de farklılık gösterir. Ancak işitme kaybı ve süresi kısa olan yetişkinler ve çocuklar kısa bir süre içinde bu sesi doğal sesler gibi algılamaya başlarlar. Bu süreç beyindeki işitme merkezinin yeni uyarılara adapte olabilmeye (plastisite) özelliğine göre çeşitli farklılıklar gösterebilir. Koklear implant ile duyulan ses örneklerini aşağıda belirtilen web sitesinden dinleyebilirsiniz.

<http://www.ucihs.uci.edu/hesp/Simulations/simulationsmain.htm>

1

İşitme kaybı dünyada
1. sırada gelen fiziksel
engeldir ama çözümü vardır.



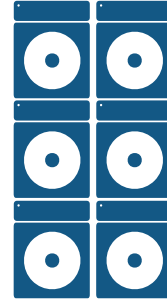
1.000
çocuk

Türkiye’de doğan her 1.000
çocuktan 3 tanesi
tamamen işitme kayıplı olarak
doğuyor.



6 Aylık bir bebek
her dilden sesleri anlayabilme
yeteneğine sahiptir.

Bunları
biliyor musunuz ?



7.5dk.

İşitme kaybının baş-
laması için bir Rock
konserinde hoparlörün
önünde 7.5 dakika dur-
mak yeterlidir.

165.000
Cochlear™
Nucleus®

Bugün Dünyada 165.000’in üzerinde Cochlear™
Nucleus® kullanıcısı :

- Artık kendilerini dünyadan izole olmuş hisset-
miyor.
- Çevreleri ile sözlü iletişim kurabiliyor.
- Müziğin, kuşların, torunlarının sesini, çocuk-
larının ilk kelimelerini duyabiliyorlar.

Baha® için
akıllı telefon ve
tablet bilgisayar
desteği...



Cochlear Baha® sistemi kullanıcılarının cihaz-
larından maksimum fayda elde edebilmeleri
için yeni bir uygulama geliştirdi. Kullanıcılar,
her nerdeyseler ve her neye ihtiyaçları varsa bu
uygulamada bulabilirler.

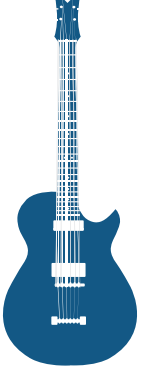


**20Hz.
20.000Hz.**

İnsan işitme eşiği 20 ile 20.000 Hz arasındadır. Köpekler 60 ile 45.00Hz, fareler 60.000 Hz'e kadar işitirken, bir yarasa ise 120.000 Hz'e kadar işitebilir.

**30.000
Koklear Implant**

Dünyada her yıl 5 milyondan fazla insan sağır oluyor ancak sadece 30.000'ine koklear implant uygulanıyor.



60%

Dünyaca ünlü Rock yıldızlarının %60'ından fazlasında işitme kaybı vardır.

**8.000
implant**

Dünya üzerinde 8000'den fazla iki taraflı implant kullanıcısı vardır.

0,00000001mm

Bir kulak zarı en az 0,00000001mm'e kadar titreşebilir. Bu bir insan saçından 100.000 kat daha incedir.



**53 milyon
insan**

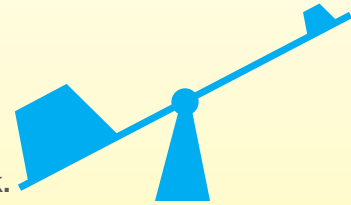
Dünya üzerinde 53 milyondan fazla insan ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı yaşıyor.



Türkiye'de giderek yaygınlaşan yeni doğan işitme taraması sayesinde, her yıl daha fazla sayıda çocuğun işitme kaybı erken yaşta tespit edilip, sessizlikten geri döndürülüyor.

**İlk Cochlear™
ses işlemcisi**

İlk Cochlear™ ses işlemcisinin ağırlığı birkaç kilo kadardı. Bugün Nucleus 5 ses işlemcisinin ağırlığı 11gr'dır. Belki gelecekte tamamen görünmez olacak.



İmplant edilebilir işitme çözümlerinde dünya lideri Cochlear, kullanıcıları için yeni Baha destek uygulamasını geçtiğimiz günlerde yayımladı.

Cochlear Baha® Destek Uygulaması, App Store ya da Android Market'den ücretsiz olarak indirilebilir. Bu uygulama Baha kullanıcıları için bilgi ve destek hizmetini kullanıcılarının ayağına getiriyor. Her nerdeyseler ve her neye ihtiyaçları varsa.

Bu uygulama Baha kullanıcılarının en sık sorduğu sorulara cevap bulmaları ve cihazlarından maksimum faydayı sağlayabilmeleri için, kullanıcı geri bil-

dirimleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Eğer kullanıcı farklı durumlarda ne yapmaları gerektiği bilmiyorsa bu uygulama onlara kolay çözümler sunuyor. Örneğin, işlemciniz ısılandığında ne yapmalısınız?

Uygulama, sorun giderme, ayarlama, temizleme ve cihaz ile seyahat gibi konularda yazılı ve videolu anlatımlardan oluşuyor. Cochlear, Baha uygulamasının Türkçe dil desteğini de Ağustos ayı içerisinde yayınlamayı planlıyor.

İşitme kaybınızı saklamanız ya da bundan utanmanız için bir sebep yok !

İşitme kaybı her yaştan insanı etkileyebilen ortak bir durumdur. Birçok işitme kaybı olan birey, bu durumu kendi içinde tutmayı tercih etmiştir. RNID (İngiltere Sağlıklar Ulusal Kraliyet Enstitüsü) tarafından yapılan çalışmada birçok işitme kayıplı bireyin bunu sosyal hayatta paylaşmadığını gösterdi. Katılımcıların yarısından azı bu konuyu çalışma arkadaşlarıyla paylaşıırken, sadece %37 si işverenleri ile bu durumu paylaştıklarını belirtti. Yapılan çalışmalara göre, araştırmaya katılanların sadece %39 u işitme kayıpları ile ilgili konuştuklarını söylerken, %16 sı ise sadece kendisine sakladığını belirtti.

Çalışmaya katılanların %43'ü durumlarından biraz utandıklarını, %28'i çok fazla utandıklarını belirtirken %28'i bir utanç duymadığını belirtti.

Muhtemelen insanların işitme kayıplarından utanmasının ve kendilerine saklamasının en önemli sebeplerinden biri, işitme kaybının yaşlı hastalığı olarak algılanması- aslında işitme kayıplı yaş ortalamalarına bakınca bunun bir yaşlı hastalığı olmadığı ortaya çıkıyor. Aslında şu bir gerçek ki, utanılacak ya da saklayacak hiç bir durum yok. İşitme engeli sanıldığı gibi sadece ileriki yaşlarda oluşan bir durum olmamakla birlikte; birçok insan için ortak bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Amerikanın Wisconsin Üniversitesinde yapılan bir çalışmaya göre; işitme kaybı problemi yaşayanların %6'sı 35 -44 yaşları arasında; %11'i 45-54 yaşları arasında; %25'i 55-64 yaşları arasındayken 65 yaş üzerinde ise %40'lık bir kesim bulunuyor.

Avrupa da işitme engellilerle gerçekleştirilen yaklaşık 45.000 katılımcının olduğu büyük bir anketin sonuçlarına göre sadece 8 kişiden biri işitme kaybı ol-



duğunu kabul ediyor. Ayrıca her üç kişiden ikisi cihazı olduğu ve cihazından fayda gördüğü halde cihazlarını kullanmıyor.

Amerika'da da rakamlar farksız. Neredeyse 35 Milyon işitme engeli problem çeken insan varken, bunların 25 milyondan fazlası işitme cihazı kullanmayı reddediyor.



İşitme Taramaları

Birçok ülkede, yeni doğan işitme taramaları yaklaşık 10 yıla yakın bir süredir düzenli olarak yapılıyor. Ülkemizde de birçok Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde, ülkenin bir çok yerindeki sağlık ocaklarında yeni doğan işitme taraması yapılıyor ve amaç ülkenin hepsini bu sisteme dahil edebilmek.

Erken tanı hem bebeklerin gelişimi hem de ailenin yaklaşımı ve desteği açısından çok önemlidir. Çocukların erken tanı konularak işitme çözümü sunulması, onların okul hayatı, sosyal hayatı ve aile hayatında birçok olumlu pencere açacaktır.

Ülkemizde de düzenli işitme taraması 1994 yılında Marmara Üniversitesinde Prof Dr. Ferda Akdaş'ın çabalarıyla başlamıştır ve yıllar geçtikçe de işitme taraması yapılan merkezlerin sayısı artmaktadır. Sizler de sizin ya da yakınlarınızın yeni doğan çocuklarının işitme taramasından geçtiğinden mutlaka emin olun.



Doğmamış bebeğinizin işitmesini koruyun

Anneler doğacak bebekleri için olası işitme kaybına erken aksiyon alıp, işitme taramaları sayesinde bu durumu erken tespit edip çözümlmeye gidebilirler. Kulak vücudumuzun karmaşık organlarından biridir ve doğum öncesi gelişiminin büyük çoğunluğunu tamamlar. Doğmamış bebeğin işitmesi birçok sebepten dolayı zarar görebilir. İşitme engeli ise en sık yaşanan doğum kusurudur. Ülkemizde her yeni doğan 1000 çocukta 2 veya 3'ü işitme engelli doğarken, bunların yarısı genetik sebeplere bağlıdır. Anne adayları bir kaç ayrıntıya dikkat ederek bebeklerinin genetik dışı işitme kaybı olmaları riskini minimum seviyeye indirebilirler.

- Sık sık el yıkamak olası enfeksiyonların önüne geçer. Özellikle "cyto-megalovirus" virüsünün sebep olduğu ve bir tür uçuk olarak adlandırılan durumların ilk 3 ayda olması bebeğin işitmesine zarar verebilir.
- Sigara içmeyi bırakın! Sigaradan kaynaklı nikotin özellikle bebeklerin koklea(Salyangoz) gelişimini etkiliyor.
- Çok yüksek sesli ortamlardan kaçının. Doğmamış bebeğe zarar verebilir.

Tedavi edilmeyen işitme kayıpları sosyal ve psikolojik problemlere sebep olabilir.

Tedavi edilmeyen işitme kayıpları, birçok sosyal ve psikolojik problemi hatta fiziksel problemi de beraberinde getirebilir. Tabi ki bu problemler kişiden kişiye değişmektedir. Amerika'da yapılan bir araştırma işitme problemi olan ebeveynler ve çocukları arasında iletişim problemi olduğunu ve çocuklara göre ailelerinin hayatlarında büyük bir şey kaçırıldığını göstermiştir. Avustralya'da yapılan başka bir çalışma ise, tedavi edilen işitme kayıplarının bireylerin sosyal hayatlarını geliştirdiği ve hatta ikili ilişkilerde daha rahat olduklarını göstermiştir. İşitme cihazları kullananların 2/3'ü aile ve dostlarıyla çok daha kaliteli vakit geçirdiğini belirtmiştir. Almanya'da yapılan bir başka araştırma sonuçları da gösteriyor ki, genç yaşta işitme kaybı yaşayan bireylerin psikolojik gerilemesi yaşlı olanlara göre daha fazla olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı, işitme kaybınız derecesine göre size uzmanlar tarafından önerilen uygun cihazı kullanmaktan çekinmeyin. Bu durum sizi hayata daha fazla bağlayacak ve hayattan daha fazla keyif almanızı sağlayacaktır.



Mimari Akustiğin Önemi

10 öğrenciden 4'ü eğitimleri sırasında çevrelerindeki seslerden rahatsız olduğunu gösteren çalışma gözleri mimariye çevirdi. Bu tür problemler muhtemelen doğru bir akustiğe sahip olmayan mimariler yüzünden meydana geliyor. İsveç'te yapılan diğer bir çalışma da gösteriyor ki, çalışmaya katılan İsveçli öğrencilerin %40'ı eğitim gördükleri sınıflarda akustiğe bağlı problemlerden dolayı rahatsız olduklarını belirtirken, eğitimcilerin %62'si ise öğrencilerin sınıfta ne dediklerini tam anlayamadıklarından şikâyet ediyorlar. Mimari akustik gerçekten çok önemlidir. Mimari Akustiği tanımlamak gerekirse; +insan faaliyetleri için tasarlanan ve inşa edilen yapılar ile insan kulağının algılayabildiği ve "ses" olarak tanımlanan titreşimlerin ilişkisini düzenleyen bilim dalıdır. Yapılan bu çalışmayı dikkate alarak aslında ülkemizde de bu tip sıkıntıların olduğunu farkına varabiliriz. Özellikle mimari olarak geniş kitlelere hizmet veren yerlerde; üniversiteler, konser alanları, kongre merkezleri, konferans salonları, ulaşım alanları gibi akustik çalışmasına daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu şekilde bireyler çevredeki seslerden rahatsız olmadan etkinliklerini konforlu şekilde yapabilirler.





Ankara'da yeni ofisimizdeyiz



FİKRET TEZAL

Müşteri Hizmetleri Uzmanı ve Eğitmeni /ANKARA

“

2012 yılı Mart ayı itibariyle faaliyete geçen yeni ofisimizde; çocuk oyun alanı ve bekleme salonu ile kullanıcıların daha rahat hizmet alması hedeflendi.

”

Cochlear Türkiye'nin merkez ofise bağlı olarak açtığı ilk ofis olan Ankara Ofisi, 2010 yılı Şubat ayı itibariyle faaliyetine başlamıştı.

Değişen ve gelişen şartlarla birlikte, firmamız kurumsal kimliğine daha uygun ve kullanıcılarımızın daha kolay ulaşabileceği yeni bir hizmet noktası arayışına girdik. Bu sebeple, yeni ofisimizi Ankara'nın en merkezi noktası olan Atatürk Bulvarı'na taşındık.

Yeni ofisimizi 2012 yılı Mart ayı itibariyle faaliyete geçirdik. Yeni ofisimizde çocuk oyun alanı ve bekleme salonu ile kullanıcıların daha rahat hizmet alması hedeflendi. Ofisimizde belli günlerde yapılan programlama hizmetinin yanında cihaz bakımı, yedek parça satışı ile arıza tespiti yapılabilmektedir.



Cochlear Ankara Ofisi

Atatürk Bulvarı,
Bulvar Palas İş Merkezi,
No:141/87 A Blok, K:7,
Bakanlıklar, Kızılay - Ankara
Tel: 0 312 435 55 68

Dry & Store yazın vazgeçilmezi



FİKRET TEZAL
Müşteri Hizmetleri Uzmanı ve Eğitmeni

Dry & Store, yani nem alma cihazı, koklear implant dış ünitelerinin, daha uzun ömürlü olması için, nemini alan vazgeçilmez bir üründür. Dry & Store nem alma cihazının kullanımı, dış ünitenin, nemin yarattığı olumsuzluklardan etkilenmemesi ve dolayısıyla da daha uzun ömürlü olması için hayati önem taşımaktadır.

Bilinenin aksine, Dry & Store tek başına cihazın nemini alamaz. Nemi toplayan, Dry Brick nem tabletleridir.

Konuşma işlemcisi, her gece, uyumadan önce temiz bir bez ile silinmelidir. Bu işlem için mikrofiber bezler en uygunu olmakla birlikte gözlük camlarını silmek için kullanılan bezlerle de konuşma işlemcisinin yüzey temizliği yapılabilir. Penye vb. bezlerin, statik elektriklenme oluşturma riskine karşı, kullanılmaması tavsiye edilir.

Nem tabletleri nasıl kullanılır? ve kullanım ömrü ne kadardır?

Temizliği yapılan işlemcinin, 675'lik kullan-at piller ile kullanılıyorsa pilleri çıkartılarak, şarjlı bataryalar ile kullanılıyorsa herhangi bir ayırma işlemi yapılmadan komple nem alma cihazına yerleştirilmesi gerekmektedir. Böylelikle hem 675'lik pilin ısınmasını önlenir hem de gereksiz kullanımı azaltarak kullanım süresi arttırılır. Konuşma işlemcisi, tüm gece, nem alıcı cihazın

içinde bekletilmelidir. Bu süreçte, nem alıcı cihazın içindeki hava, ısıtılacak, herhangi bir nemlenme var ise buharlaşarak, cihazın fanı sayesinde, nem tabletlerine hapsolacaktır. Nem tabletlerinin kullanım süresi 2 aydır.

Her gün ortalama 8 saat yapılması gereken bu işlem, cihazın ömrünü arttırıp, cihazı uzun vadede oluşabilecek arızalanmalardan koruyacaktır. Havalarda her zaman nemli olmasa da vücut ısı ve terleme, cihazınızın nemlenmesine sebep olur. Şunu iyi bilmeliyiz ki, konuşma işlemcisinde gözle görülebilir bir nemlenme var ise, işlemcinin içinde de nemlenme var demektir. Bu yüzden, nem almak hayati önem taşımaktadır.

Cihaz, her gün tavsiye edildiği gibi, koruma ve bakım tavsiyeleri gözardı edilmeden kullanılmalıdır.

İki taraflı işitme sistemi ile işitme potansiyelinizi maksimuma çıkartın

İki kulak tek kulağtan daha iyidir.



İki kulağınızda birden duymayı sağlanmış dinleme şeklinizi değiştirir
ve işitmenize yeni bir potansiyel katarken yaşamınızda da yeni bir kapı açar getirir.

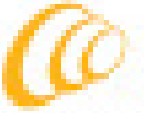
- **Daha güvende hissedin** - Sesin kaynağını daha kolay anla
- **Katıl** - Herkesin bir parçası ol
- **Bakarla** - Dinlemenin keyfini çıkar

İnsanları birleştirir - Dünya lideri - Vizyon sahibi - Yapam için çözümler

Daha detaylı bilgi için lütfen web sayfasına ziyaret ediniz.
www.cochlear.com.tr

Cochlear and the stylized logo are trademarks of Cochlear Limited. H0880001 0101 A0000

Hear now. And always


Cochlear

Doç.Dr. Gonca SENNAROĞLU

En büyük hayalim;

Memleketin bütün köşelerine ulaşmak,
çocukların en erken dönemde teşhis
almalarını sağlamak, uygun yaklaşım ile
gereken desteği ulaştırmak.



Hacettepe Üniversitesinin en sevilen hocalarından Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu ile odyoloji bilimine, öğrencilerine ve hastalarına adanmış hayatı üzerinde keyifli bir sohbet yaptık.

Sizin gözünüzle Gonca Sennaroğlu kimdir?

İnsanın kendini anlatması zordur. İki baskın huyum vardır mesela. Birincisi; hayır demeyi bilmemem. Bir diğeri de kafama taktığımı yapmamdır. Şimdi bunu okuyanlar ve beni tanıyanlar eminim onaylıyorlardır. Kafama koyduğumu yapmak için hedefimin peşinden koşarım. Çoğunda da başarıya ulaşmışımdır. Ama bazen "hayır" demeyi de bilmem lazım. Aslında bunun odyoloji ile ilgisi yok, hangi meslekte olursam olayım yine şimdiki gibi olurum diye düşünüyorum. Hiçbir zaman kısa, özet ve yarım yamalak iş yapmayı sevmedim. Özellikle söz konusu hastalarımın onlara kendimden daha çok zaman ayırıyorum. Artık hastalarımın hepsi de beni çok iyi tanır. Onları kırmayacağımı bildikleri için habersiz çıkıp gelirler, hayır demeyi bildikleri için. Ama böyle yapmasınlar burdan onlara sesleniyorum;

Beni zor durumda bırakmasınlar.

Odyolojinin hangi dalını daha çok seviyorsunuz?

Tabi ki pediatrik odyoloji. Pediatrik odyolojiyi ilk girdiğimden beri çok seviyorum. Aslında buna koklear implantın eklenmesi tesadüf olmuştur. Sevgili Prof. Dr. Erol Belgin hocamın yaptığı bir toplantıda "İlerlemek için herkesin bir konu üzerinde yoğunlaşsın" diye bir önerisi olmuştur. 1996'da yılında yapılan bu toplantıda bana koklear implant düşmüştü. O zaman hiçbir şey anlamamıştım. Ben bu konu ile, bu kadar pahalı bir cihaz ile ne yapacağım diye düşünmüştüm. 1997'de Amerika'ya House Ear Institute'e gittiğimde koklear implantın gelişmeye müsait bir alan olup, ne kadar yararlı ve gerekli olduğunu ve başarıları beraberinde getireceğini gördüm. Hocama bir kez daha teşekkür ediyorum. Aslında fizyoterapist olarak çalışmaya devam etseydim de ilgi alanım değişmezdi diye düşünüyorum. Yine bebek ve çocuklarla çalışırdım. Erişkinler ile çalışmak kolay olsa bile çocuklar kadar keyif alamıyorum. Aileleri ile bir şeyleri paylaşmak, bebeklerin büyüdüğünü, çocukların birer ergen olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Bir pediatrik odyolog olarak bebek ve çocuklar için çok hayallerim var...

Ne gibi hayalleriniz var?

Memleketin bütün köşelerine ulaşmak, çocukların en erken dönemde teşhis almalarını sağlamak, uygun yaklaşım ile gereken desteği ulaştırmak. Özellikle ailelerin işitme kaybı nedenleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmelerini, daha ileriye nasıl gidebileceklerini öğrenmeleri için onlara zamanında bilgi vermek. Gerisi sürpriz.

Peki, koklear implant kullanan ailelerin çocuklarına yaklaşımı nasıl olmalı?

Koklear implant kullanan bebeğin ve çocuğun başarısının kesinlikle aileye bağlı olduğunu düşünüyorum. Aslında bu sadece koklear implant için değil

işitme cihazı için de geçerli. Ama burada cerrahın, klinik odyoloğun ve tabii ki eğitim odyoloğunun rolünü de göz ardı etmemek lazım. Aileler destekleyici olmalı ve asla pes etmeden çabalamalıdır. Gelişmelerini paylaşmalı, küçük değişikliklere bile sevinmelidir. Erken kabullenip bebeklerini erken desteklemeleri gereklidir. En iyi takibi alacağı kişi ve kurumları seçmelidirler. Ailelerin bir kısmı çok bilinçli değiller aslında. Bütün yükü doktorlarına ve odyologlarına bırakıyorlar. Zaman içinde elbette öğreniyorlar ama bu sürecin daha kısa olması, çocukları için daha yararlı olacaktır.

İşaret dili hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ulusal TV kanalları ve bunun gibi mecralarda kullanımı yaygınlaşmalı mı?

Kesinlikle gerekli olduğunu ve eğitimimizin bir parçası olması gerektiğini düşünüyorum. Mümkün olsa birçok vakanın mesela beyin sapı hastalarının ameliyatı beklerken işaret dilini öğrenmeleri faydalı olacaktır. Bir örnek vermem gerekirse; Yeni beyin sapı ameliyatı olan bir hastanın annesi 1 yıl önceden işaret dili eğitimi aldı ve programlama yaparken iletişimde faydalarını gördük. İşlemci takıldıktan 19 gün sonra aile beni aradı ve 'çocuğumuz 'miyav' dedi' diye sevinçlerini paylaştı...



Koklear implant kullanan bebeğin ve çocuğun başarısının kesinlikle aileye bağlı olduğunu düşünüyorum.

Peki, biraz da sosyal hayatınızdan bahsederseniz; iş dışında nelerle vakit geçirirsiniz?

Alışverişten ve yemek yapmaktan çok hoşlanırım. Son zamanlarda bir de bahçe işlerine merak saldım, beni gerçekten çok rahatlatıyor.

Çok başarılı ve ünlü bir cerrah ile evlisiniz. İş ve özel hayatınızın dengesini nasıl bu kadar iyi ayarlıyorsunuz?

Her ikimiz de profesyonel anlamda işi eve taşımamaya çalışıyoruz; ama bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Tabii ki mesleki ve bilimsel anlamda birbirimize olumlu katkılarımız da oluyor. Özellikle hastalarımızla ilgili güzel gelişmeleri, bazen problemleri paylaştığımız, fikir alışverişini yaptığımız zamanlar da oluyor..

Bizlere vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz...

Çocuklarda işitme kaybı ve odyolojik değerlendirmenin önemi



Doç. Dr. Günay KIRKIM

İşitme, sesin kulak tarafından algılanarak beyne iletilmesi sürecidir. Sağlıklı, normal işiten bir bebek, çevresindeki sesleri dinler. Ses uyaranlarını gördüğü objelerle bağdaştırır, kodlar ve kavram geliştirir. Sıralanan tüm bu işlemler neticesinde kelimeler üreterek konuşmaya başlar.

Çocukların dil edinim süreci olan 0-3 yaş döneminde, sesli uyaranın beyne iletilmesinde meydana gelen bir aksaklık, konuşma ve dil becerisinin normal gelişmemesine neden olur. Doğumla başlayan süreçte işitme kaybının olumsuz etkileri, bebek büyüdükçe artar. Dil ve kavram gelişiminin engellenmesi ileri yıllarda sosyal, akademik ve mesleki yaşamı da etkiler.

İşitme kaybının derecesine göre konuşma gelişimi de farklı derecelerde etkilenir. Hafif derece işitme kayıpları okul dönemine kadar gözden kaçabilirken, ileri veya çok ileri derecedeki işitme kayıpları, dil ve konuşma geriliğine neden olmakta ve daha erken dönemde fark edilmektedir. Hafif ve orta derece işitme kaybında işitme cihazı yeterli gelirken, ileri/çok ileri derece işitme kaybı olan çocuklar son teknolojiye göre geliştirilen güçlü işitme cihazlarını kullansalar dahi, işitme cihazlarından kısmi yarar sağlarlar. Çocukların konuşmaları anlamasında güçlükle yaşamalarına neden olan bu durum, konuşma üretimi ve iletişim becerisinde yetersizliğe neden olur.

Normal bir akademik ve sosyal gelişim için, işitme kaybı derecesi ne olursa olsun bebeğin/çocuğun her iki kulağına da işitme cihazı önerilmelidir. İşitme cihazı ile yeterli işitmenin sağlanamadığı ileri veya çok ileri derece işitme kaybı olan çocuklara cerrahi yöntemle koklear implant takılır. Erken

koklear implantasyon, dil gelişimi ile beraber, okuma ve yazma becerilerini de olumlu yönde etkiler. Bu çocuklar, daha geç yaşlarda implant olmuş akranlarına kıyasla okuma, yazma ve akademik becerilerde daha başarılı olmaktadır.

Koklear implantasyona uygun aday belirlemek için tıbbi ve psikolojik kriterler göz önüne alınır. KBB hekimleri, odyoloji, radyoloji, psikoloji ve nöroloji uzmanlarından oluşan kurul tarafından implant adayı belirlenir. Çocuğun kronolojik yaşı ve ailenin koklear implantasyona hazırlık dönemindeki tutumları da önem taşımaktadır. Ülkemizde yenidoğan işitme taraması programının başlaması neticesinde, geçmiş yıllara göre işitme kaybının tanı yaşı, işitme cihazı kullanma yaşı ve koklear implantasyon yaşı düşmüştür. Bu yaş grubu olgularda işitme cihazı veya koklear implant öncesi odyolojik değerlendirmenin uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu değerlendirme sonucunda aşağıdaki soruların cevaplandırılması gerekmektedir.

1. İki kulağın işitme seviyeleri nedir?
2. İşitme normal değilse, kalıcı işitme kaybı var mı?
3. 0.5, 1, 2 ve 4 Hz'de işitme eşikleri nelerdir?
4. Çok ileri derece işitme kaybı varsa, rezidüel işitme var mı?
5. İşitsel Nöropati/Senkronizasyon bozukluğu var mı?
6. Diğer testler tanıyı destekliyor mu?

Pediyatrik hastalarda işitme kaybı tipinin koklear, iletim veya retrokoklear mı?" olduğuna odyolojik test bataryasındaki objektif ve subjektif testlerin uygulanması sonucunda karar verilir. İşitsel fonksiyonlar; ABR (Auditory Brainstem Response- İşitsel Beyinsapı Cevapları), akustik immitansmetri, otoakustik emisyon gibi objektif ölçümlerle ve davranışsal gözleme dayalı, görsel pekiştireçli odyometri veya hastanın kooperasyonu uygunsa (genellikle 3 yaş üzeri) oyun odyometrisi ile değerlendirilir. Objektif testlerden temel elektrofizyolojik bir test olan ABR yaygın olarak kullanılmaktadır. Pek çok klinikte, sadece klik uyaran kullanılarak yapılan hava yolu ABR sonuçları dikkate alınmaktadır. Ancak, işitme kaybı kısmi bir frekans aralığında ise,

“

İşitme cihazı ile yeterli işitmenin sağlanamadığı ileri veya çok ileri derece işitme kaybı olan çocuklara cerrahi yöntemle koklear implant takılır. Erken koklear implantasyon, dil gelişimi ile beraber, okuma ve yazma becerilerini de olumlu yönde etkiler.

”



“

Aile, çocuğun düzenli cihaz kullanımını sağlamalı ve dil gelişimini arttırmak için eğitimi hayat biçimi haline getirmelidir.

”

klik uyaran odyoğrafı şekli hakkında bilgi vermez. Özellikle bebek ve çocuklarda saf ses eşliğini saptayamadığımız durumlarda eşik ABR kullanışlı bir yöntemdir. Klik nöral senkronizasyona neden olur, frekansa özgü bir uyaran değildir. Klik, logon ve burst uyaran kullanılarak elde edilen eşik ABR ile frekansa özgü bilgi sağlanabilir. Frekansa özgü bilgi uygun eğitim için gerekli olan işitme cihazı seçiminde yarar sağlar.

Yenidoğan işitme taramasında kalan bebeklerin 3 aylık dönemlerinde eşik ABR'nin yanısıra endikasyon varsa kemik yolu ABR de kullanılarak işitme kaybının derecesi, tipi ve şekli belirlenir. Davranım odyometrisinin yapılamadığı küçük çocuklarda koklear rezervi değerlendirmede daha fazla bilgi edinmek için mutlaka hava ve kemik yolu ABR birlikte yapılmalıdır.

Pediyatrik popülasyonda hava yolu ABR testi, klinik odyolojik katkılarının iyi bilinmesine rağmen, iletim tipi işitme kaybı ve sensorinöral işitme kaybı arasındaki gerçek ayrımı sağlamaz. Hava yolu ABR'de işitme kaybı varsa, bebeklerde kronik otit vb durumlarda kemik yolu ABR'nin de yapılması önerilir. Kemik yolu ABR eşikleri dış ve orta kulak patolojisi (yarık damak, aural atrezi ve otitis media vb) yenidoğanlarda normal koklear hassaslığı göstermeyi sağlar.

Pediyatrik grubun odyolojik değerlendirmesinde objektif testlerin önemli bir yeri vardır. Ancak bir testin objektif olması demek, doğru tanıya götürüyor demek değildir. Uygun test bataryasının kullanılarak, testlerin doğru yorumlanması gerekir. Bazı durumlarda, elektrokokleografi, elektrik ABR, işitsel sistemin maturasyonunu ölçmek için kortikal yanıtların değerlendirilmesine de gereksinim duyulabilir.

Nitelikli bir odyolojik değerlendirme neticesi, işitme cihazı veya koklear implantlı rehabilitasyon programına alınan çocukların dil gelişiminde, anne ve babaya da çok önemli görevler düşmektedir. Aile, çocuğun düzenli cihaz kullanımını sağlamalı ve dil gelişimini arttırmak için eğitimi hayat biçimi haline getirmelidir.

Uzman Odyolog ve KBB hekimi tarafından uygun hasta seçilip; Bir Baha® çözümü edinmeye karar verildikten sonra, en önemli konu hangi ses işlemcisinin – kullanılacağına karar vermektir. Baha sistemi bu konuda kendini sürekli yenilemekte ve hastalara 45dB'den 65dB'e kadar çözüm sunmaktadır.

Baha® 3

Sistemi ile seslerin keyfini çıkarın...

Baha® 3 sistemi



Nihai hedef, en etkili implant ve doğru ses işlemcisi sayesinde, hastaların yaşam kalitesini arttırmaktır. Kafatasına sabitlenen saf titanyum implant ; yalnızca 4,5 mm çapında ve 4 mm uzunluğundadır, yani oldukça küçük ve saçın içerisinde rahatlıkla saklanabilmektedir.

Cochlear™ 2010 yılında, eski nesil implanttan tecrübeleri ile Baha 3 İmplantı (B1300) geliştirdi.

Baha® 3 geliştirilirken temel amaç: İmplant stabilizesini arttırmak, ses işlemcisinin mümkün olduğunca kısa süre içerisinde kullanımlarını sağlamak ve cilt reaksiyonlarını minimuma indirmektir. Bu nedenlerle, yeni implant piyasaya sürülmeden önce, kullanılan tüm teknoloji, yoğun klinik çalışmalara tabi tutulmuştur.

Stabil implant neden önemli?



Gerçek Boyut

Yeni implant, TiOblast® adlı kısmen pürüzlü bir malzemeden üretilmiştir. Bu malzeme sayesinde, gerçek yüzey alanı artar ve düz yüzeyli cihazlara kıyasla, kemikle çok daha kolay kaynaşır ve stabilizesi artar. Klinik araştırmalar, Baha 3 İmplant'ın artan stabilizesi ile ameliyattan ses işlemcisinin takılmasına kadar geçen süre, 12 haftadan 3 haftaya inebilmektedir.

Stabilizesi implantın güvenilirliğini de olumlu yönde etkilemektedir. Daha stabil Baha 3 implantı çocuklar gibi yumuşak kemikli kişiler için de ideal bir seçimdir.

Daha az cilt reaksiyonu için yeni tasarım

Bazı Baha kullanıcıları implantasyon sonrasında cilt tahrişleri yaşamakta ve bunlar nadiren ciddi sorunlara yol açmaktadır. Daha ileri cilt sorunları riskini azaltmak için abutment bağlantısının şekli ve bağlantısı değiştirilmiştir. Abutment, implantın 'bağlığı' olup cilde giren ve ses işlemcisini bağladığınız parçadır. Yeni şekil cildi stabilize etmeye yardımcı olarak yukarı hareket etmesini engeller.

Klinik araştırmadan elde edilen sonuçlar yeni Baha 3 implant ve abutmentin önceki türlere göre cilt tahrişlerini ciddi derecede azalttığını göstermektedir. Ameliyattan altı ay sonra, yeni destek takılan hastaların yalnızca %3,9'unda profesyonel tedavi gerektiren bir cilt reaksiyonu görülmüş olup bu oran önceki destekte %16,7'dir.

Peki ya Ses İşlemcileri?

Cochlear Baha ilk programlanabilir ses işlemcisini Divino'yu BP100'e geçirek yaptı. 45 db'e kadar kayıpları olan hastalara fayda sağlayan bu cihaz ile hastaların konuşmayı anlama oranları arttı. Programlanabilir özelliği ile 3 farklı program seçeneği sunan Baha 3, estetik görünümüyle de hastalarından olumlu geri bildirim almaktadır.

“

Hasta kayıtlarının da tutulabildiği bu sistem sayesinde, en komplike vakalarda, en ince ayarları yapmak bile mümkün.

”

Sıra daha fazla işitme kaybı olan hastalara çözüm sunmaya geldiğinde; Intenso cihazı yerine yeni programlanabilir BP110 Power cihazına geçiş yapıldı. Bu sayede 55 db'e kadar kayıpları olan hastalar da programlanabilir cihazın keyfini çıkartabilecekler.

Baha 3 sisteminde neler değişti, neler yenilendi?

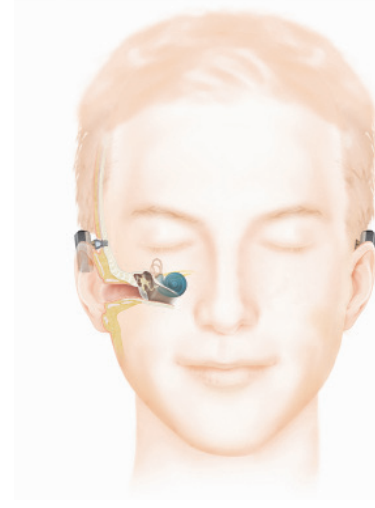
- Hastaların işitme kazançlarındaki ciddi seviyede artışın yanında, konuşmayı anlamalarında da %53'lük bir artış gözlemlendi.
- "Dynamic Output Stabiliser" teknolojisi sayesinde, yüksek frekanslarda çok daha başarılı sonuçlar elde edildi.
- Otomatik karar verme özelliği; pozisyon ve yön kabiliyetini geliştirdi; gürültülü ortamlarda otomatik olarak arka sesleri bastırmaya, otomatik ses kontrolü yapmaya, olası bir geribildirim durumunu elemeye ve ani keskin sesleri yumuşatmaya göre programlandı.
- Geliştirilen mikrofon koruması sayesinde nem ve rüzgâra daha dayanıklı bir cihaz üretildi.
- Ayarlanabilen 3 farklı program; "Her gün, gürültü ve audio" programları sayesinde hastaların maksimum fayda sağlanması amaçlandı.

Cihazın teknik özellikleri yanında, hastalar için kullanımı da daha kolay ve estetik hale getirilen BP110 Power; 6 farklı temel renk seçenekleri ile çeşitli hasta ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlarken; çocuklar için de ayrı renk çeşitlerini ve kilitleme seçeneğini içeriyor.

5 yaş altındaki çocuklar için çeşitli softband seçenekleri ise ayarlanabilir uzunluk özelliği katılarak yenilendi.



Baha 3 implantı ile ameliyattan ses işlemcisinin takılmasına kadar geçen süre, 12 haftadan 3 haftaya inebilmektedir.



Baha Sistemi, vücudun titreşimler aracılığıyla sesleri doğal duyma yeteneğinden faydalanır. Kemik ses iletimi cihazları, bir sebepten ötürü dış kulak ya da orta kulak işlevini yerine getirmediğinde, ses titreşimlerini doğrudan kafatası kemiğinin içinden iç kulağa gönderir.

Kolay Programlama

Baha 3 sisteminin bir diğer gelişen parçası ise, ses işlemcilerini ayarlamakta kullanılan program oldu. Bu program Odyologlar tarafından, daha kısa sürede basit adımlarla, hastanın ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama amacıyla geliştirildi. Hasta kayıtlarının da tutulabildiği bu sistem sayesinde, en komplike vakalarda, en ince ayarları yapmak bile mümkün. Hem BP100 hem BP110 için kullanılan programı, hastaneler ve merkezlerde bilgisayarlara ürün sorumlularımız tarafından yüklenmektedir.

Bu tasarım ve teknolojik değişiklikler, sürece dahil olan herkes için yararlı olacaktır. Daha hızlı osseointegrasyon, daha erken ses işlemci uyumu ve ameliyat sonrası daha az doktor ziyareti, daha iyi performans ve yüksek hayat kalitesi... Etrafınızdaki seslerin keyfini daha erken ve güvenli bir şekilde sürebilmeniz için gereken her şey...

Bir çocuğa herhangi bir hastalık teşhisi konulduğunda buna alışmak zaman alabilir ama asıl odak noktası, durumu kabul etmek ve bu beklenmedik koşulla nasıl yaşanacağını öğrenmektir.

Baha® ile daha iyi işitme



Seslerin farkına varma yeteneği çocukluktaki öğrenme ve dil gelişimi için çok önemlidir. Ancak pek çok durumda ebeveynlere işitme kaybının dil gelişimini ve öğrenmeyi etkilediği de tedavisinin mümkün olduğu da söylenmemektedir. Bu nedenle mevcut bir yardımın olduğunu ve daha iyi bir işitmenin hem çocuğun hem de tüm ailenin yaşam kalitesini arttırabildiğini bilmek gerekmektedir.

Baha Sistemi, vücudun titreşimler aracılığıyla sesleri doğal duyma yeteneğinden faydalanır. Kemik ses iletimi cihazları, bir sebepten ötürü dış kulak ya da orta kulak işlevini yerine getirmede, ses titreşimlerini doğrudan kafatası kemiğinin içinden iç kulağa gönderir. İşitme sağlığı uzmanları bu tür sorunlarda Baha'nın geleneksel işitme cihazlarına göre daha etkili bir çözüm olduğunu kabul etmektedirler.

Burada, Baha Sisteminin, en iyi çözüm olduğu birtakım sağlık durumlarını sizlerle paylaşacağız.

Down Sendromu

Konuşma algısını ve bilişsel gelişimi uyarmak için işitme kaybının mümkün olduğunca erken yaşlarda tedavi edilmesi hayati öneme sahiptir, özellikle de Down Sendromlu çocuklarda. Bu çocuklar, işitme kaybına sebep olabilecek yüksek kronik kulak enfeksiyonları ve sinirsel iletim sorunları riskiyle karşı karşıyadır. Özellikle dar kulak kanalları Down Sendromunda yaygın olarak görülen bir durumdur.

Baha çözümü, geleneksel işitme cihazlarının bu tür çocuklarda sıklıkla yaptığı gibi tahrişe ve rahatsızlığa sebep olmadan, sesin kemiğin içinde yol almasını sağlar. Erken yaşlarda uygulanabilen bu çözüm Down Sendromlu çocukların küçük yaşlardan itibaren duyabilmesine ve dil öğrenebilmesine olanak verir.

Tek taraflı işitme kaybı

Tek taraflı işitme kaybı olarak da bilinen bir kulakta aşırı işitme kaybı; doğuştan kaynaklanabileceği gibi, hastalıklar veya diğer tıbbi durumlar, yüksek



“Baha® çözümü kullanan atrezi veya mikroti durumlu çocukların konuşma ve dil açısından diğer arkadaşları kadar iyi gelişme gösterdikleri görülmektedir.”

Bir Baha çözümünün size nasıl yardımcı olabileceği konusunda daha fazla bilgi almak isterseniz;

0800 261 71 81

telefon numarasından ya da info-tr@cochlear.com adresinden bize ulaşabilirsiniz.



seslere maruz kalma, travma veya tanımlanamayan faktörler sonucunda da meydana gelebilir.

Tek taraflı sağır olan bir kişi gürültülü bir ortamda konuşmaları anlamakta ya da çalan bir telefon gibi seslerin yerini belirlemekte zorlanabilir. Baha sistemi hasarlı taraftaki sesleri doğrudan diğer taraftaki işlevli kulağa iletir. Bu da konuşmaların anlaşılmasına yardımcı olur ve etrafınızdaki tüm seslerin algılanmasını sağlar.

Yarık dudak ve damak

Yarık dudak ve/veya damak yaklaşık her 1500 – 2000 canlı doğumun 1'inde meydana gelir. Bu çocuklarda, orta kulak hastalıkları işitme kayıpları (öskaki borusunu açan kaslar etkili bir şekilde çalışmadığı için) yaygın olarak görülür.

Yarık dudak ve/veya damakla doğan çocuklarda tipik olarak öncelikle, orta kulak havalandırması eksikliğinin sebep olduğu, iletim tipi işitme kaybı görülür. Baha Softband bu çocuklara normal dil gelişimini ciddi derecede kolaylaştıran gerekli ilk aşama güçlendirmesine (ses yükselmesine) katkı sağlar.

Atrezi/Mikroti

Atrezi/mikroti ile doğan çocuklarda iletim tipi işitme kaybına yol açan kulak malformasyonları görülür. Bu da çocukların kokleasının (iç kulak) iyi çalıştığı ancak sesin ona ulaşabileceği bir yolun bulunmadığı anlamına gelir. Birçok durumda bu çocuklar geleneksel işitme cihazlarını kullanamazlar. Baha Sistemi sesi kemik yoluyla ileterek onu doğrudan işlevli iç kulağa yönlendirir.

Çalışmalar, Baha çözümü kullanan atrezi veya mikroti durumlu çocukların konuşma ve dil açısından diğer arkadaşları kadar iyi gelişme gösterdiklerini ortaya koymaktadır.

Kronik Orta Kulak İltihabı

Çocukların çoğu, zaman zaman kulak enfeksiyonları geçirir, ancak bu enfeksiyonların kronik hale gelmesi, iletim tipi işitme kaybına yol açabilen orta kulak sorunları riskini arttırır. Çocukta kulak enfeksiyonunun meydana geldiği durumlarda, kulak kanalına geleneksel işitme cihazlarının takılması imkansız hale gelebilir ve bir süre sonra rahatsız etmeye başlar. Baha sistemi kulak kanalını asla engellemediği için kronik kulak enfeksiyonlarıyla ilişkili akıntılar düzgün şekilde kurumasına olanak verilir, böylece sorunların tekrarlama riski azaltılmış olur.

Treacher Collins sendromu

Treacher Collins sendromu kafatası yapı bozukluğuna sebebiyet veren, çok nadir görülen kalıtsal bir hastalıktır. Treacher Collins sendromlu bebekler genellikle biçimsiz ağız ve gözkapaklarına yol açan gelişmemiş çenelerle ve işitme kayıplarına yol açan biçimsiz dış ve orta kulaklarla doğarlar. Baha sistemi, vücudun sesleri titreşimler yoluyla duyma doğal yeteneğinden yararlanır. Baha, sesi doğal yolla yeniden yönlendirir. Ayrıca, Baha Softband işitme kaybı olan çocuklar için çok önemli olan erken müdahale olanağını da sunmaktadır.



ŞAN(S)LIURFA'DA YEKTA

İşitme yetersizliği olan çocuklara verilen eğitimin profesyonelliği ve kalitesi bu çocukların ileriki yaşamlarına hazırlanabilmesi ve üreten birer birey olabilmeleri için çok önemli. Bu anlamda Şanlıurfa'da yaşayan ve işitme güçlüğü çeken çocuklar çok şanslı çünkü bu özel çocuklara ve ailelerine onların hak ettiği eğitimi veren bir kurumu var.



Yekta Rehabilitasyon merkezi 2001 yılından bu yana işitme engelli çocuklara rehabilitasyon ve eğitim imkânı veriyor. Yekta'nın kurucusu İbrahim Yaşar Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünden mezun, doğru ve etkin bir eğitimin önemine inanan bir eğitimci. Kurumunda da kendisi gibi işine bağlı, çocukları seven, işitme engelliler alanından mezun 10 öğretmen, 1 grup öğretmeni, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 psikolog ile birlikte toplam 13 kişilik bir uzman kadro bulunuyor.

İşitme engelli aileleri Yekta Rehabilitasyon ve Eğitim merkezi tarafından verilen ilgiden oldukça memnun. Kurucu müdür İbrahim Bey bu başarının altındaki temel nedenleri şu şekilde özetliyor;

İlk görevimiz eğitim

Bizim öncelikli misyonumuz eğitimidir. Yani işitme yetersizliği olan çocukların doğru bir eğitim alarak ailelerinin de bilinçlenmesini sağlayarak kendimize bir misyon edindik.

İkinci unsur ise tabii ki eğitimi veren kadronun kalitesidir. Eğitim kadromuzun bu işin eğitimin almış uzman eğitimcilerden oluşmasına öncelikle özen gösteriyoruz.

Üçüncü unsur ise verdiğimiz eğitimin kalitesidir. Kurumumuzda her bir bireyin ihtiyacına uygun ders programları ve ailelerin etkin katılımıyla işitme yetersizliği olan öğrencilerimizin eğitim devamlılığı esas alınmıştır.

Şanlıurfa'da İşitme engelliler ve ebeveynleri ile kocaman bir aile...

Biz bir aileyiz

Son bir unsur daha söylemek gerekirse bizim bu başarımızın altında bir aile olmamız yatmaktadır. Kurumda öğrenci ile eğitimci, eğitimci ile aile, aile ile diğer aileler arasındaki iletişim ve ilişkiler birer aile ilişkisidir. Biz onları ailemiz olarak görüyoruz, onlar geldiğinde kendi evlerine gelmiş oluyorlar. Bütün bu unsurlardan sonra başarısız olma ihtimalimiz yoktur.

İşitme Kayıplı Çocuklarda Dinlemenin Önemi



Uzm. Ody.
Şenay ALTINYAY



İşitme kayıplı çocuklarda anlaşılır ve yaşitları düzeyinde dil-konuşma gelişimine sahip olabilmenin ilk basamağı erken çocukluk döneminde iyi dinleyici olmaktan geçmektedir. Ayrıca dinleme becerisi, pek çok kavram ve bilgiyi öğrenilmesinde, okul öncesi ve okul dönemi akademik gelişimin sağlanmasında temel oluşturmaktadır. Yaşam boyu aktif olarak kullanacakları dinleme becerisini işitme kayıplı çocuklarımıza mümkün olan en erken dönemde kazandırma hedeflemeliyiz.

Radyoyu/CD çaları her açtığınızda ya da telefonu her kullandığınızda neler olduğunu düşünürsek konuşmayı öğrenmemiz için işitmenin önceliğinin ne kadar önemli olduğunu fark edebiliriz. Eğer normal bir işitme yetisine sahipseniz, herhangi başka bir duyu organınızı kullanmadan da, tek başına dinleme becerisine dayanarak konuşmacıyı anlayabilirsiniz. Bu durum konuşmanın her şeyden önce diğer duylardan bağımsız akustik bir olay olmasından kaynaklanmaktadır. Diğer duylarımız -özellikle koklama, tatma ve dokunma- etrafımızdaki insanların konuşmalarının anlaşılmasında oldukça sınırlı bir kullanıma sahiptir. Sadece görme belirli oranlarda işitmeyi destekleyen ve tamamlayan bir duydur.

İşitme dışındaki duylarımızın hiçbirisi, konuşmacının yaptığı konuşmanın özelliklerinin net bir şekilde anlaşılması konusunda, işitme sistemimizin sağladığı bilgileri ve verimliliği sağlayamaz. İşitme sistemimiz, konuşma sırasında meydana gelen hız değişimlerine, aynı hızda ve aynı anda olan konuşma seslerine cevap verebilir ve de bunlar arasında oldukça iyi bir ayırım yapabilir.

İşitme kaybı, çevre ve konuşma seslerini duyulmasında hem miktar hem de kalite açısından engelleme neden olmaktadır. İşitme kaybının derecesi arttıkça seslere erişim güçlüğü göstermekle birlikte duyabilen seslerin ayırt edilmesi de zorlaşmaktadır.

Ülkemizde yeni doğan işitme tarama çalışmalarının her geçen gün giderek yaygınlaşması, işitme kayıplı çocuklarda erken tanıyı mümkün hale getirmiştir. Erken tanı, erken cihazlandırmayı olanaklı hale getirerek, bebeklerin çok daha kısa sürede ses ile tanışmaları şansını yaratmıştır.

Koklear implantlar, işitme cihazları ve kişisel FM cihazlarının teknolojilerinin sağlanan gelişmelerin hepsi, çok ileri derecede işitme kayıplılar da dahil, tüm işitme sorunu yaşayan çocukların artık sese daha kolay ve daha net bir şekilde erişimine olanak yaratmıştır. Bu gelişmeler, konuşmanın dinleme yoluyla öğrenilmesini, işitme kayıplı çocuklar açısından en önemli ve etkili bir seçenek haline getirmiştir.

"Erken yaşlarda koklear implantlar ile duyabilmek, beyindeki işitme merkezlerinin gelişimi için çok önemlidir."

“

İşitme, sesin kulaklarınıza ulaşmasıyla, dinleme ise beyninize ulaşmasıyla gerçekleşmektedir.

”

Son yıllarda yapılan araştırmalar bize, erken dönemde işitsel uyarılmanın, beyin organizasyonunda ve nöral aktivitede, ölçülebilir farklılıklar yarattığını göstermektedir. Burada anlatılmak istenen, erken yaşlarda duyabilmenin beyindeki işitme merkezlerinin normal gelişimi için çok önemli olduğudur. Ayrıca, erken yaşta takılmış koklear implant yardımıyla sese erişim sağlayan çocuklardaki işitsel algı ve dil becerilerinin, geç yaşta sesleri duymaya başlayanlara göre çok önemli derecede ilerleme gösterdiği diğer araştırmalarda belirtilmektedir.

Bütün bu bilgiler dinleme becerilerinin gelişiminde, konuşmanın farklı tonlarına yeterli ve düzenli bir erişimin gerekliliğine dikkat çekmektedir. Çocuklar, dinlemeyi ve konuşmayı öğrenebilecekleri ortamlarda eğitim aldıklarında, işitme potansiyellerini en üst seviyeye çıkarabilmektedirler.

Dinleme becerisi neden eğitim almayı gerektirir?

Öncelikle işitme ile dinleme arasındaki farkı ortaya koymak gerekmektedir. Kısaca işitmeyi “kulak ile algılama”, dinlemeyi ise “dikkatli işitme” olarak tanımlayabiliriz. Ayrıca, işitme, sesin kulaklarınıza ulaşmasıyla, dinleme ise beyninize ulaşmasıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle işitme otomatik gerçekleşirken dinleme pratik gerektirmektedir. Dinleme becerisi, günlük yaşam içinde yapılacak pratikler ile kalıcı ve sürekli hale getirilebilir.

Ailenin Rolü

Anne-babalar, çocuklarına bakan ve onların gelişimlerinde anahtar rol oynayan kişilerdir. Anne-babaların çocuklarının gelişimindeki rolü doğumla birlikte başlayıp, yaşam boyu devam etmektedir. İşitme engelli çocuğun eğitiminde de en etkin ortam, sürekli içinde bulunduğu, kendini güvende hissettiği sıcak aile ortamıdır. Erken tanı ve koklear implant kullanımı ile birlikte ailenin erken dönemde çocuğunun konuşma ve dil gelişimine aktif destek sağlama sorumluluğu daha da önemli hale gelmektedir. İşitme kayıplı çocuklara dinlemeyi ve konuşmayı öğrenmelerine olanak tanıyacak kolaylaştırıcı ortamlar sağlamak için, yapılması gereken şeyler bulunmaktadır.

İyi bir dinleme ortamı sağlamak için evde neler yapabiliriz?

1. Ebeveynlerin yapacağı önemli ve ilk adım, çocuğun uyanık olduğu saatler boyunca koklear implantını /işitme cihazını takması sağlamaktır. Bu adım hem dinlemeyi hem de konuşmayı öğrenmesinde temel teşkil etmektedir.
 2. Ebeveynler, tüm iletişim ortamlarında, çocuğun etrafında bulunan dinleme koşullarının bilincinde olmalıdır.
- Çocuğa iyi bir işitme fırsatı vermek için arkadan gelen gürültünün, yok edilmesi ya da azaltılması gerekmektedir. Bu konuda gerektiğinde FM sistemlerinden faydalanılmalıdır.

- Diğer bir yapmamız gereken, konuşmacı ile çocuğun mikrofonu (koklear implant/cihazı) arasındaki uzaklıktır. Özellikle dinleme eğitimine ilk başlanılan günlerde bu mesafe en fazla 30-40 cm kadar olmalıdır. Yüksek sesle konuşmak, mesafe sorununu çözmeyecektir; çünkü konuşmanın yüksek şiddette olması net ve anlaşılır olmayı olumsuz etkiler.

3. Normal ses tonu ve hızda konuşulmalıdır.
 4. Ritim ve ifade açısından zengin melodik bir ses tonu kullanılmalıdır. Sesinizde iniş çıkışlar ve tonlamalar kullanmanız dinlemesini etkin hale getirecektir.
 5. Çocukların herhangi bir iletişime yönelik etkileşim sırasındaki dinleme becerilerinin geliştirilmesi için, anne-babaların uygulayabilecekleri diğer bazı stratejiler şunlardır:
- Çocuğunuzun, yüzü size bakmayacak şekilde dizinize oturtunuz ya da onun arkasına oturunuz. Çocuğun dikkatinin, birlikte oynadığınız oynarken veya aktivitede olduğundan emin olunuz. Çocuğunuzun mikrofonuna yakın konuşunuz.
 - Çocuğun, sizi dinleyerek anlaması için fırsat veriniz. Burada önemli olan çocuğunuzla tekrarlı ve rutin olaylar ya da ilgi duyduğu oyuncaklarla oynama sırasında dinleme becerisi edindirmektir.
 - Eğer çocuğunuz, yalnızca işitsel özellik taşıyan bir mesajı anlamamış gibi görünüyorsa, söylediğiniz şeyi tekrar etmeye ve çocuğun mikrofonuna yakın konuşmaya çalışınız. Çocuğunuz, buna rağmen anlamıyorsa, göstererek ve sonra da, yalnızca işitsel olarak söylediklerinizi tekrar ederek, anlamasına yardımcı olunuz.

Uzman- Aile İşbirliği

Dinleme becerisinin gelişim aşamaları kendi içerisinde pek çok alt basamaktan oluşmaktadır. İşitme kayıplı çocuklara, bütün basamaklar doğru ve etkili bir eğitim programı çerçevesinde uygulanarak kazandırılmalıdır. Uzmanlar ailelere rehberlik etmeli ve günlük yaşamda neyi-nasıl yapacaklarını eğitim oturumlarında ailelere uygulamalı olarak göstermelidirler. Ancak bu şekilde işitme kayıplı çocuklar, yaşamları boyunca aktif olarak kullanacakları etkin dinleme becerisine sahip olabilirler.

Dinleme becerilerini işitme kayıplı çocuklarımıza erken dönemde doğru ve etkili bir şekilde kazandırabilirsek beraberinde dil ve konuşma becerileri de o kadar iyi ve hızlı bir şekilde gelişecektir.

“Gömleğin ilk düğmesi yanlış iliklenince diğerleri de yanlış gider.”

İyi bir dinleme ortamı için;

- Aile veya eğitimci çocuğun yanında ve iyi işiten kulağının olduğu tarafta oturmalı.
- Çocuğun koklear implantının ya da işitme cihazının mikrofonuna yakın konuşulmalı.
- Normal ses tonu ve hızda konuşulmalı.
- Arka plan gürültüsü azaltılmalı.
- Ritim ve ifade açısından zengin melodik bir ses tonu kullanılmalı.

“İşitme problemim o kadar ilerlemişti ki çocuklarımdan, eşimden bana “pulsuz” mektuplar geliyordu artık. Çünkü başka türlü anlaşılamıyorduk.”

Cemal Çelik

Yıllardan beri gidemediğim

sinemaya, tiyatroya gidebiliyorum artık... ↘

Cemal Çelik 55 yaşında ve yaşamı sunuculuk, dernek çalışmaları, semah gösterileri ve daha birçok sosyal zenginliklerle dolu hoş sohbet bir insan. Kendisi 2008 yılından beri Koklear İmplant kullanıyor. Cemal beyle koklear implant öncesi ve sonrası hayatında değişenler üzerine güzel bir sohbet yaptık.

Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? İşitme probleminiz ne zaman ve nasıl başladı biraz bahseder misiniz?

İsmim Cemal Çelik 1957 Tokat doğumluyum. Emekli serbest muhasebeciyim. Kulak rahatsızlığım 1980'li yıllarda baş dönmesi ve seslerin gevrekleşmesi ile başladı. İlk etapta aklıma tansiyon geldiği için baş dönmesi nöbetlerinin olduğu zamanlarda ölçtirdüğüm tansiyonum normal çıkıyordu. Sorunun ne olduğunu bilmediğimden bir hastahenenin dahiliye bölümüne başvurdum. Yapılan tetkiklerden bir şey çıkmayınca dahiliye beni KBB bölümüne yönlendirdi ve en hafif tabirle serüven başlamış oldu.

Zor bir süreçti sanırım...

İlk başladığı zamanlarda ayda bir, iki ayda bir gelen nöbetler gittikçe sıklaşmaya, zaman dilimi daralmaya başladı. Bu dönemlerde doktora gidiyor, ilaç tedavisi görüyordum. Doktorumun “hastalığın ilerlemeyecek ama kap-

lumbağa hızıyla tedavi edeceğiz” demesine “yavaş olmasına razıyım, yeter ki sonuç alalım” diyordum. Aslında dayanılır, tahammül edilir gibi değildi nöbetler. Baş dönmesi seslerin gevrekleşmesi gibi belirtilere “müthiş bir uğultu” eşlik etmekteydi. Duyduğum uğultunun şiddetini anlayabilmek için kafanızın içinde uçak kalktığını düşleyin, o ortamda ne kadar sağlıklı işitirseniz, söylenenleri ne kadar doğru anlarsanız ben de o kadar işitiyor ve anlıyordum. Yıllarca ilaç kullanmama rağmen nöbet aralıkları daralıyor, buna bağlı olarak da yaşam standartım düşmeye başlıyordu. Daha yirmi yirmi beş yaşlarındayken böyle bir ortamda yaşamak beni kahrediyor, tıbbın çaresiz kalmasına isyan ediyordum. Doktoruma; “tıp çok ilerledi diyor-sunuz, basit bir uğultuya çare bulamıyorsunuz, bu nasıl ilerlemedir?” deyip isyanımı dışı vurduğum anlar bile oluyordu.

Bu nöbetler meslek ve özel yaşamınızı da etkiledi mi? Size nasıl çözümler önerdi doktorlarınız?

Mesleğim gereği telefon görüşmeleri yapmam, birebir insanlarla konuşmam, seminerleri takip etmem gerekliydi ama ben bunların hiçbirini yapamaz olmuştum. Çünkü nöbetler artık yirmi dört saate yayılmış, günlük yaşantımın bir parçası olmuştu. Müthiş bir uğultuyla arkadaşım artık her yerde benimleydi. Doktorum işitme cihazı önerdi. Kabul ettim. Kulak arkası işitme cihazı kullanmama rağmen problem çözüme kavuşmamıştı. Yaşantım altüst olmuş, abartılı bulacaksınız belki ama “hayatım kararmıştı”. Söylenenleri anlayamadığım için sinirli olmuştum. En ufak bir şey beni sinirlendiriyor bu da aile yaşantımıza yansıyor. Eşimle, çocuklarımla konuşamaz olmuştum. Aile içi yazışmalar başlamıştı. Çocuklarımdan, eşimden

bana "pulsuz" mektuplar geliyordu artık. Çünkü başka türlü anlaşıyor-duk. Yolda bir dostumu, arkadaşımı gördüğüm zaman bana bir şey söyleyecek ve ben yine anlayamacağım korkusuyla ya görmezden geliyor, ya da yolumu değiştiriyordum. Yolda birisi beni durdurup " bizim evi " bile sorsa cevabım sorduğu soruyu anlamadığım için "bilmiyorum" oluyordu. Kendi çabamla dudak okumayı öğrenmiştim. Dudak okumayla yakaladığım şeyler olursa söze karışıyordum ama bazen yanlış anlayıp futbol tabiriyle "ofsayta" düştüğüm anlar da oluyordu. İşte o anlar benim için yıkım oluyordu.

Çalışıp didinerek belli bir seviyeye getirdiğim işyerimi 2005 yılında kapatmak zorunda kaldım. Çevremizde çok aktif bir yaşıntım varken git gide pasif bir yaşama dönüştü günlerim. Sunuculuktan dernekçiliğe kadar hareketli bir yaşam durağan, basit ve içe kapanık bir hal almıştı ve bu durum beni daha çok üzmekteydi. Yaşıntım bu kadar sıradanlaşmışken bile bir gün olsun "yenildim" demedim, hep "seni yeneceğim" ümidini içimde canlı tuttum. Bu dönemlerde gittiğim bir doktor bana yeni bir ümit ışığı yaktı, biy-onik kulaktan bahsetti. Bu sıkıntılı durumu biy-onik kulakla aşabileceğimden söz etti. Aslında bu tabir bana yabancı değildi, gazetelerde biy-onik kulakla ilgili bir haber okumuştum.

Koklear implant ameliyatınız nerde gerçekleşti?

Hiç beklemediğim bir yerden bana yardım eli uzandı. Sayın Ahmet Necdet Sezer'in yardımlarıyla, İstanbul'da oturmama rağmen Hacettepe Üniversitesi KBB servisine yönlendirildim. Çeşitli testler ve tetkikler yapıldıktan sonra biy-onik kulak için uygun olduğuma karar verildi. 01 Mayıs 2008 yılında yatışığım Hacettepe Üniversitesi KBB servisinde 05 Mayıs 2008 günü ameliyat olacaktım. Ameliyat öncesi doktorumla yaptığım görüşmede "size ne takmamı istersiniz " dedi. Ben de "insanlarla rahat sohbet edebileceğim, söylenenleri anlayabileceğim ne var ise onu takın" deyince o güne kadar hiç duymadığım iki kelime telaffuz etti " Cochlear implant ". Duyduğum uğultu yüzde elli azalacak, insanlarla rahat sohbet edeceksin dediği zaman doktora şüpheyle bakmıştım. 05 Mayıs 2008 tarihinde Prof. Dr. Ergin Turan tarafından ameliyat edildim.

Bize biraz ameliyat sonrası ilk ayarlamalarınızın yapıldığı günden de bahseder misiniz?

Ameliyat olduktan sonra dış bağlantı için gün verildi. 03 Haziran 2008 günü tekrar hastaneye gidecektim. Eşimle beraber gittim Ankara'ya. Doçent Dr. Gonca Sennaroğlu tarafından cihazın dış bağlantısı programlanıp takıldı. Gonca hanım bana bir şeyler söyledi, ben hayretle doktorumun yüzüne bakıyordum. Nasıl bakmam ki! İlk kez, evet yıllar sonra ilk kez bana söylenen cümlelerin tamamını anlıyordum. Bu harika bir şeydi. Gonca hanıma "hocam, ilk kez bana söylenenlerin tamamını anladım" dediğimde eşimin, benim hatta doktorumun bile mutluluğumuz yüzümüzden okunmaktaydı. Doktorum bana dönüp, "altı ay, altı ay sonra sesler kişilik kazanacak, yerli yerine oturacak ve sen çok daha iyi anlayacaksın" dedi. Dedigi de oldu. Her geçen gün ben Cochlear implanta alışmaya başladım.

İlk günlerde seyredemediğim televizyona alıştım, telefonla konuşmaya alıştım, her geçen gün sesler yerli yerine oturduğundan bu eşimin sesi, bu filanın sesi diye sesleri ayırt etmeye başladım. Artık sohbet edebiliyor, yolda eşimi dostumu gördüğüm zaman görmezden gelmiyordum. Yıllardan beri gidemediğim sinemaya, tiyatroya gidebiliyordum artık. Yaşıntım normale dönmeye başlamış, sinirliliğimden eser kalmamıştı. Tetkikler sırasında Prof. Dr. Erol Belgin'in söylemiş olduğu "benimle sohbet edeceksin" cümlesi gerçek olmuştu.

Şunu samimiyetle itiraf etmeliyim ki; ben de bu kadar güzel bir sonuç

beklemiyordum. Teşekkürler Prof. Dr. Ergin Turan, teşekkürler Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu. Ve teşekkürler beni Hacettepe Üniversitesi KBB servisine yönlendiren yüce insan Ahmet Necdet Sezer. Yeniden doğmama sebep oldunuz. Teşekkürler Cochlear implant.

"Şunu samimiyetle itiraf etmeliyim ki; ben de bu kadar güzel bir sonuç beklemiyordum. Teşekkürler Prof. Dr. Ergin Turan, teşekkürler Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu."





İsinizi ne kadar iyi yaparsanız, o kadar iyi anılırsınız ↘

Prof. Dr. Yahya Güldiken
İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi

Türkiye’de koklear implant denildiğinde akla ilk gelen hocalarımızdan Prof. Dr. Yahya Güldiken ile kariyeri, sosyal yaşamı ve düşünce dünyası üzerine samimi bir söyleşi yaptık.

Biraz kendiniz bahseder misiniz? Tıp fakültesine girişiniz, KBB uzmanlığını tercih etme sebebiniz, kısacası bu başarı öyküsü nasıl başladı?

İlkokuldan sonra şanslı bir şekilde Galatasaray Lisesi’nde dört yıl ortaokul dört yıl da lise olmak üzere sekiz yıllık bir eğitim aldım. Tıp fakültesi ilk yıl ilgimi çekmemişti. Ancak ikinci yıldan sonra zevk alacağım bir işim olacağına karar verdim. Sonrasında cerrahi bir branşta uzmanlaşmak istedim.

“Tasavvuf benim için bir yaşam biçimi”

O dönem genel cerrahlara eli bıçak tutan dahiliye uzmanı diyorduk. Kalp-damar cerrahisi ilgimi çekiyordu ama o da büyük bir ekip işiydi. Kendi kendime dedim ki büyük bir ekibe ihtiyaç duymadan neyi en iyi yapabilirim? Üç seçeneğim vardı; üroloji, göz ve KBB. O dönemde göz alanında uzmanlaşmak çok zordu, üroloji de pek ilgimi çekmiyordu, dolayısıyla KBB’de karar kıldık. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB uzmanlığı sınavlarına katıldım ve başarılı oldum. Ferda Hoca (Aktaş) bir önceki sayıda dünyaya yeniden gelsem yine odyolog olmak isterim demiş. Ben de aynı şekilde dünyaya bir daha gelsem yine KBB uzmanı olmak isterim. Çok zevkli bir dal, çok zevkli bir uğraş. Rahmetli Hocam Behbut Cevanşir ve Hocam Nermin Başarer ile birlikte Baş-Boyun cerrahisindeki deneyimlerimden sonra 2005 yılında, kendimi otolojide ve özellikle koklear implantta buldum. Bu cerrahinin manevi boyutunun çok yüksek olduğunu gördüm. Hastalardan ve ailelerinden bize yansıyan pozitif enerji bizi ayakta tuttu ve bu konuda ilerlememize, derinleşmemize vesile oldu.

Ameliyatlarda da tanık oluyoruz, hep ilk günkü gibi tatlı bir telaş içindesiniz. Sizi motive eden şeyler neler?

Bizim mesleğimiz çok kutsal bir meslek ve Allah’ın bize verdiği bir nimet. Çünkü O’nun yarattığı en mükemmel varlıkla meşgölüz; Yunus Emre’nin sözündeki gibi “Yaratılanı severim, yaratanı dan ötürü”. Biz hastalarımıza ne kadar sevgi ve saygıyla yaklaşırsak inandığımız Allah’a veya Tanrı’ya daha yakın olmak, O’nun sevgisine mazhar olmak mutluluğuna da o kadar çok erişiriz. Bu durum bendeki tasavvufi görüşle de tam anlamıyla uyşmaktadır. Otolojinin bendeki en önemli yeri de sonucu görerek mutlu olmak ve bu mutluluğu hastalarla paylaşmak diyebilirim. Koklear implant uygulamasında sonucun çok hızlı ve abartılı bir şekilde ortaya çıkması insanı son derece mutlu ediyor.

Avrupa ve Amerika ile kıyaslandığında, sizce Türkiye’de işitme kaybının tanısı ve tedavisi hangi seviyede bulunuyor?

Tabii Türkiye’de son on yıla baktığımızda bu alanda büyük atılımlar yaptığımızı görüyoruz. Özellikle koklear implantasyonun tamamının ülke genelinde SGK tarafından ödeniyor olması kadar muhteşem bir şey olamaz. Aynı şekilde yüksek maliyetli kemiğe implante işitme çözümlerinin de SGK tarafından ödendiğini görüyoruz. Bu durum bizim tıp ve sağlık alanında geldiğimiz noktanın önemli bir göstergesidir. Cerrahi, odyoloji ve bütün ekibin hazır olduğu ülkelerden biriyiz. Ayrıca implantın fiyatının Avrupa’yla mukayese edilemeyecek kadar düşük olması da bizim için büyük bir avantajdır. Bugün Libya, Irak, Makedonya, Azerbaycan’dan yani hem yakın hem uzak coğrafyadan hastalar Türkiye’ye implantasyon için geliyorlar. Türkiye’de çok sayıda yabancı hastanın ameliyatını gerçekleştirebiliyoruz. 2005 yılına değin yılda 100-150 ameliyatın yapıldığı bir ülkede şu anda 700-900 aralığında ameliyat yapılıyor. Dolayısıyla o dönem 2-3



cerrahin yaptığı ameliyatlar, şu anda 30’un üzerinde merkezde yapılabilir duruma geldi. Bu sayılar da bizim bu konudaki gelişmişliğimizin bir göstergesi olsa gerektir. Böylelikle bir yarışma ortamı da sağlamış oldu. Yurtdışındaki projelere ülkemizden katılımlar oluyor. Oradaki çalışmalara katkılar sunuyoruz. Arkadaşlarımızın yurtdışı kongrelerinde, panellerinde konuşmacı olarak dinlenmesi göğsümüzü kabartan konular arasındadır.

Sizin de koklear implantasyonun uygulanması ile ilgili bir çalışmanız bulunuyor.

2005 yılından sonraki iki yıllık dönemde Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde koklear implantasyon gerçekleştirdim. Biliyorsunuz, implantı yerleştirmek için kafatasının turlanması gerekiyordu ve bana göre bu da çocuklarda çok büyük sıkıntılara yol açıyordu. Çünkü kafatasında 3 mm’lik bir bölümün turlanması, implantımızın direkt olarak duraya temas etmesine sebep oluyordu. Darbelerde, şoklarda duranın hasarı söz konusu olacağı için çok mutlu değildim. Plastik cerrahiden esinlenerek periost dediğimiz zarı dekore ederek, yani ayırarak o bölümde implant için bir cep oluşturmayı düşündüm ki periost, kemiğe çok sıkı yapışır. Dolayısıyla aklımda, o sıkı yapışan doku implantı yerinde sabit tutar düşüncesi vardı. Çocuklardaki gelişen osteogenesis yani kemikleşmenin artış sürecinde vücudun kendi yuvasını kendisinin yapacağını düşünüyordum. Yaklaşık kırk vakanın sonunda yaptığımız kontrollerde, implantın yerinden oynamadığını, komplikasyonlarımızın azaldığını gördük. Çünkü turla herhangi bir şey açmıyorsunuz, yatak açınca implantınızla kulak arkası cihazınız çakışabiliyor, kulağa çok yakın olabiliyor, ensizyon hattına değebiliyor ve daha öne getirmek durumunda kalabiliyorsunuz. Kırk vakalık bir seriden sonra ben bunu yakın çevreme anlatmaya başladım. Önceleri genellikle olumsuz yaklaşımlar oldu. Fakat beni kurtaran, koklear implant alanında dünyaca tanınan Amerikalı Thomas Balkany’nin o dönemde bir dergide bu yönde bir makalesinin yayınlanması oldu. Birbirimizden habersiz yaptığımız çalışmalarda komplikasyonların azaldığı ve implantla ilgili sorun yaşanmadığı sonucuna varmışız. Şu anda üç yüzün üzerinde vakamız var. Yeni yetişen uzmanlarımıza bu yöntemi tavsiye ediyoruz ve bu yöntem tercih ediliyor. Bu yöntem hem ameliyat süresini kısaltıyor, hem gelebilecek darbelerin direk beyne ulaşmasını engelliyor. Ameliyat süresinin kısılması da hastanın post-op dönemi daha rahat geçirmesini sağlıyor.

Hem koklear implantta hem de kemik iletimli implantlarda hastalar bir ameliyat geçiriyor. Hastalarınızın tereddütlerini nasıl yok ediyorsunuz ve ameliyat sonrası nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Koklear implantasyondaki en büyük korku bu cerrahinin menenjit, yüz siniri felci ve benzeri travmalara açık bir alan oluşturması, hastanın düşme-



ve bunun dışında kulak akıntılarına bağlı enfeksiyon riskinden dolayı hem cihazı kullanamıyorlar hem de cihazın performansı düşüyor. Kemik iletimli çözümlerde ise gözlük tipi işitme cihazları var. Ancak görüyoruz ki hastaların çoğunluğu bu cihazlardan memnun kalmıyor. Başlangıçta belirli bir kazanım olduğu için memnun oluyor. Ancak daha sonra ortaya çıkan cızırtılı sesler ve ses kalitesinin giderek düşmesi sonucunda hasta bu cihazlardan vazgeçebiliyor. Şu anda kemik iletimli çözümler konusunda Avrupa'nın gerisindeyiz. Ama çok iyi sonuçlar alıyoruz. Ameliyat ettiğimiz hastaların geri dönüşleri çok mükemmel oluyor. Memnuniyetin çok güzel ve yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Özellikle çift taraflı masteodektomi operasyonu geçirmiş hastalarda memnuniyet çok yüksek oluyor. Çünkü konvansiyonel işitme cihazları bu hastalara fayda sağlamıyor.

Hep bilim insanı yönünüzden bahsettik, peki Yahya Güldiken sosyal hayatta nasıl bir profil çiziyor?

35'li yaşlara kadar futboldan çok zevk alırdım ve aktif olarak oynardım. Galatasaray Lisesi'nin lise takımının değişmez oyuncusuydum. İyi bir Galatasaray taraftarıyım. Ayrıca Galatasaray Divan Kurulu üyesiyim. Tabii şu anda fiziksel durumumu çok fazla zorlamamak için futbol yerine yürüyüşlerle spor açığımı kapatmaya çalışıyorum. Seyahat etmeyi çok severim. Türkiye içinde de yurtdışında da özellikle tasavvuf yönü bulunan yerleri ziyaret etmeyi çok severim. Tasavvuf büyüklerinden Mevlana, Yunus Emre, Hacı

si sonucu implantın arızalanması ve tekrar tekrar ameliyat olma riskiydi. 2005'ten sonraki dönemde ameliyat sayıları arttıkça ve hasta memnuniyetine yönelik geri dönüşler oldukça bu durum tersine döndü. Çünkü hastalar birbirlerini eğitim kurumlarında görüyorlardı ve sonuçların şaşırtıcı oluşu tüm tereddütleri yok ediyordu. Önceden bizim ikna etmeye çalıştığımız hastalar koşu koşu bize gelmeye başladı. Biz insanlara o dönem ne olur gelin, bunun zamanını geçirmeyin, bu zaman geçerse ameliyat olsa da bir işe yaramaz diyorduk. Ancak insanlar küçücük bebeklerini, çocuklarını, onlara göre böyle bir ameliyata atmak, feda etmek istemiyorlardı. (Gülüyor.) Sonrasında bizim çocuğumuz işitme cihazı kullanıyordu, tek tük kelimeleri öğrenip telaffuz ediyordu, bizden çok sonra gelip koklear implant ameliyatı olan çocuklar bizimkileri koşar adım geçtiler, demeye başladılar. Böyle olunca da çocuğunu kapam bize getiriyordu. Tabii komplikasyonları söylemek zorundayız. Bu aynı ilaç prospektüsünü okuyup ilaç kullanacağım, zehir mi yutacağım demek gibi bir şeydir. Ama komplikasyon sayımız gerçekten çok az, dünya standartlarında olabilecek en düşük komplikasyon sayılarına sahibiz, diyebilirim.

Şu anda kemik iletimli işitme çözümleri konusunda da SGK'nın öngördüğü bazı gelişmeler var. Sizce hangi hasta grupları Baha'dan yarar görebilir?

Tabii şu anda SGK tarafından biraz kısıtlı bir hasta grubunun tedavisi karşılanıyor. Özellikle Konjenital Çift taraflı Kulak Atrezileri. Bu hastaların doğduktan hemen sonra işitmenin daha iyi gelişebilmesi için erken dönemde cihaz kullanması gerekiyor. Bu hastaların öncelikle Baha'yı softband ile kullanması daha sonra da implantasyonun yapılması son derece ideal bir çözüm ve biz de bu çözümü kullanmaya başladık. Çünkü bu tip hastaların bir orta kulak cerrahisinden yarar göreceği tartışmalı olabilir. Ayrıca çift taraflı masteodektomi operasyonu geçirmiş hastaların konvansiyonel işitme cihazı kullanmalarında büyük sorunlar bulunuyor. Havalanamama, terleme

“
**Galatasaray
Lisesi futbol
takımının değişmez
oyuncusuydum.
Şimdi de Galatasaray
Divan Kurulunun
üyesiyim.**”

Bektaş-ı Veli gibi isimlerin düşünce dünyasını incelemek ve felsefelerini anlamak için yaşadıkları yerlere ziyarette bulunmayı, yerinde görmeyi tercih ederim. Tasavvuf büyükleriyle olan muhabbetimi arttırmaya ve onları ziyaret etmeye gayret ederim. Onun için seyahat etmeyi çok seviyorum.

Hem Türkiye’de hem de yurtdışında başarılı bir KBB cerrahisi olarak anılıyorsunuz. Bir sırrınız var mı ya da öğrencilerinize ne tavsiye ediyorsunuz?

Benim konumumda olup benden çok daha donanımlı ve başarılı arkadaşlarım olabiliirdi. Ancak biz, kader silsilesinde İstanbul Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Fakültesi’nde bir öğretim üyesi olabildik. Bu durumun benim çok çok başarılı, çok çok becerili olmamdan ziyade kaderin yönlendirmesinin sonucu olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada bulunmak bize verilmiş bir görevdir. Kesinlikle büyüklük kompleksine kapılmadan, hep tevazu kanatları altında size takdir edilmiş bu görevi layıkıyla yapmanız gerektiğine inanıyorum. Bu görevi yaparken de insanları sevmeniz lazımdır. İnsanları seviyor-

sanız, onlara değer veriyorsanız, siz kendinizi seviyor ve değer veriyorsunuz demektir. Sizi yaratanın sevgisini de talep ediyorsanız bunu yapmanız lazımdır. Bunlar yirmili otuzlu yaşlarda fark edemediğimiz, ancak kırklı yaşların sonunda içindeki, özünüzdeki hissiyatla algıladığınız; anlatılması zor, kişiye özgü, hissedebildiğiniz şeylerdir. Ben yetiştirdiğim talebelerime hep şunu söylüyorum: Yaptığınız işin gururuna kibrine girmeyin, bunu sizden iyi yapacak birisi mutlaka olacaktır. Siz olmasanız da bu iş yapılacaktır. Ama yaptığınızı iyi yaparsanız sizi iyi anarlar ve bu sizi mutlu eder. Hem toplum içerisinde hem kendi içinde hem de bilim dünyasında mutlu olursunuz. İşinizi tevazu ile yaparsanız yükselirsiniz, gurur ile yaparsanız kendi egonuzda yükelebilirsiniz, ancak insanların gözünde gizli bir şekilde alçaldığınızı bile hissedemezsiniz. Sizi insanların yüceltmesi lazım, siz kendinize paye biçmeyin. Mesela çok ilginç bir şey var. Ameliyatta bir şeyi ben yaptım diye gururlandığımda o gün başıma gelmeyen kalmıyor. Ama bu ameliyat bana verildi ve ben bunu en güzel bir şekilde yapmalıyım dediğimde her şey çok daha kolaylaşıyor. Burada ilahi bir gücün olduğuna inanıyorum ve bu yüzden de tasavvuf benim için bir yaşam biçimidir.

“

“Çok sayıda yabancı hastanın ameliyatını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz”

”



İşitme Kaybının *Aile-Çocuk Etkileşimi* *Üzerindeki Etkisi*



Uzm. Ody.
Zerrin TURAN

Doğumdan başlayarak çocukla kurulan etkileşim dilin gelişmesi için gereken en önemli etkenlerden biridir. Bilindiği gibi konuşmayı öğrenmek için sadece işitiyor olmak yeterli değildir. Dil gelişiminin sağlanabilmesi için, işitmenin yanı sıra konuşulan bir ortamda bulunmak ve dilin nasıl kullanılacağını öğrenmek de gereklidir. İşitmesi normal olan ancak kendisiyle konuşarak iletişim kurulmayan çocukların dil gelişiminde gecikmeler veya bozukluklar olduğu yapılan araştırmalarla gösterilmiştir.



İşitme kayıplı çocuklar söz konusu olduğundaysa dil gelişimini sağlamak için çocukla kurulan etkileşim ayrıca önem kazanmaktadır. İşitme kayıplı çocuklarda dil gelişiminin sağlanması açısından çocukla kurulan etkileşim de son derece önemlidir. İşitme cihazı veya koklear implant yoluyla sese erişim sağlandıktan sonra bile işitme kayıplı çocuk ve ailesi arasındaki etkileşimde ortaya çıkan aksaklıklar işitme kayıplı çocukların dil gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

İşitme kaybı sık rastlanan bir durum olmadığı için birçok aile işitme kaybı saptandığı zaman çocukları ile nasıl iletişim kuracaklarını bilememektedir. Bu nedenle eğitimcilerin, aileyi çocuklarının dil gelişimini destekleyecek etkileşim stratejilerini kullanmak üzere yönlendirmesi ve çocuklarıyla doğal-normal bir ilişki geliştirmeleri için desteklemesi gerekmektedir. Aileler doğru yönlendirilmediklerinde çocuklarıyla girdikleri etkileşimler sonucunda çocuğun dil gelişimini olumsuz yönde etkileyecek sıkıntılar gözlenebilmektedir.

Ailenin benimsediği yanlış etkileşim stratejileri çocuğun yaşına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Eğer çocuk bir yaşından küçük ya da bir yaş civarındaysa iletişim normal veya normale yakın olabilmektedir. Çocuğun yaşı büyüdükçe, iletişim içinde çocuğa dair beklentiler artmaktadır. Anne-babanın iletişim girişimlerine iştirme kayıplı çocuğun beklenen düzeyde cevap vermemesi normal ana-baba-çocuk ilişkisini değiştirerek, zaman zaman her iki taraf için de hayal kırıklığı yaratan durumların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Dolayısıyla erken teşhis ve eğitimin normal iletişim biçimlerini koruma ve sürdürmede büyük önemi olduğu ileri sürülebilir. Bu nedenle hayatın ilk yılı içinde teşhis, cihazlandırma ve eğitim aile-çocuk etkileşimini bozulmadan korumak ve dil gelişimini hızlandırması açısından son derece önemlidir.

Doğal, normal iletişim

Konuşma dilini geliştirmemiş, normal işiten bir bebek ile anne-babası arasındaki etkileşim incelendiğinde aşağıdaki durumlar gözlenmektedir:

- İlişkiyi çocuk yönetir. Anne-baba çocuğun ilgisini izler ve ne yapmak istediğini anlamaya çalışır,
- Çocuğun ilgilendiği nesneyle ilgili konuşur, oyun yaparlar,
- Çocuğun kendisine söylenenleri anladığını varsayarlar.

Konuşma o anda var olan olaylarla ilgilidir. Çünkü bu yaştaki çocukların ilgisi kolayca görebilecekleri yakın çevrelerindeki olaylara ve nesnelere yöneliktir. İşitme kayıplı çocuklarla aileleri arasındaki etkileşim incelendiğinde ise aşağıdaki özelliklerin biri veya birkaçı gözlenebilmektedir:

- Aile dil öğretme çabası içine girerek çocuğun ilgisini takip etmez,
- Ortak ilgi olsa bile çocuğun anlamayacağı düşüncesiyle kısıtlı bir dil kullanarak kelime öğretmeye çalışılır,
- Anne ya da baba sürekli konuşma ihtiyacı hissederek çocuğa konuşması için fırsat vermezler,
- Hiç konuşmayabilirler.

Anne-babanın çocukla yaşantı paylaşmasına fırsat sağlayan ve oluşan ortak yaşantılara bağlı olarak dil gelişimine yönelik stratejilerin vurgulandığı eğitimler yoluyla anne-babalarda görülen ve dil gelişimini kısıtlayan bu tip etkileşim hataları engellenebilir veya düzeltilebilir. Bununla birlikte eğitimin bir süreç olduğu, değişimlerin, zaman içinde yavaş yavaş ortaya çıkacağı eğitimler sırasında hatırlanmalıdır.

Bu Değişiklikler Neler Olabilir?

- Daha zengin dil kullanımı,
- Ortak ilgi ve anlamlı dil kullanımında gelişmeler,
- Oyunları geliştirmede daha yeterli hale gelme,
- Çocuktan gelen açılımları değerlendirme ve ona fırsat tanıma,
- Doğallığın artması.

“

İşitme kayıplı çocuklarda dil gelişiminin sağlanması açısından çocukla kurulan etkileşim de son derece önemlidir.

”



Dil gelişiminin sağlanabilmesi için, işitmenin yanı sıra konuşulan bir ortamda bulunmak ve dilin nasıl kullanılacağını öğrenmek de gereklidir.



Mutluyum Özel Eğitim Merkezin'de

Güler Yüzlü Titiz Eğitim, Ailelerin de Yüzünü Güldürüyor

Mutluyum Özel Eğitim Merkezi, 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert bile yoktur' ilkesi ile 2003 yılında Gaziantep'te kurulmuştur.



Eğitim merkezinde, işitme yetersizliğinden dolayı dil gelişim sorunu yaşayan ve işitme yetersizliği olmadığı halde kekemelik, artikülasyon bozukluğu, gecikmiş konuşma, ses bozukluğu gibi dil ve konuşma sorunu çeken ve özgül öğrenme bozuklukları yaşayan kişilere, deneyimli, güler yüzlü ve uzman bir kadroyla hizmet veriliyor.

İşitme engelliler için kişiye özel eğitim

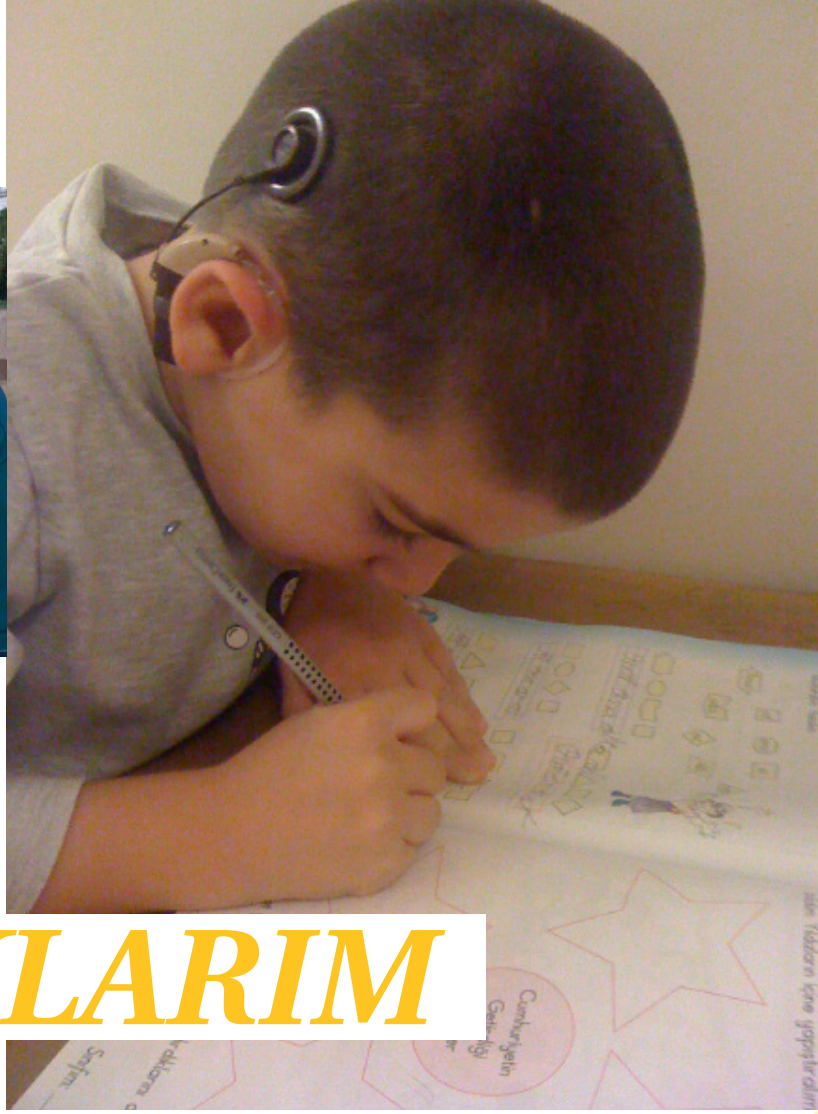
İşitme yetersizliği olanlar için, kişiye özel; sesi fark etme, dinleme, ayırt etme, anlama, ifade etme, sözel dili üst düzeyde kullanma yetisini kazandırma çalışmaları titizlikle uygulanıyor. Ayrıca ses yalıtımlı bireysel/grup eğitimi sınıfları, müzik odası, uygulama evi gibi tümüyle amaca yönelik alanları da bulunan kurumda, özel hazırlanmış eğitim materyalleri ve daha da önemlisi özel eğitime gönül vermiş deneyimli uzman bir kadro ile işitme engelli çocuklarla teker teker ilgileniliyor. Programların hızını ve başarısını arttırmak amacıyla aile eğitimi uygulamalarına büyük önem veren merkez, ebeveyni aktif kılarak günlük rutinlerin sözel kazanımlara dönüşmesini hedefliyor.

Tüm bu çalışmalarla birlikte, odyoloji-dil ve konuşma bozuklukları uzmanı ile dil ve konuşma bozuklukları programını Gaziantep'te uygulamaya açan ilk ve tek kurum olması Mutluyum Özel Eğitim Merkezini daha da önemli bir noktaya taşıyor.

Çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyorlar

Eğitim merkezine devam eden çocuklar, müzik odası, uygulama evi gibi aktif öğrenme faaliyetleri ile öğrenme sürecini keyifli bir şekilde yaşamının yanında kurum bünyesinde gerçekleştirilen yılsonu, bayram, yılbaşı gibi çeşitli etkinliklerle de hem eğleniyor hem de sosyal gelişim ve iletişimlerini artırma şansını yakalıyor.





Mehmet Ertan BAŞGÜL

Kulaklarım KULAKLIKLARIM



Sorunsuz geçen bir hamileliliğin 29. haftasında sürpriz bir şekilde kardeşimle beraber erkenden dünyaya geldik ve adına “kuvöz” denen camdan bir kutunun içinde yaşama gözlerimizi açtık. Sürekli beyaz önlüklü teyzeler başımıza geliyor, burnumuzdan ağızımızdan bize mama veriyor, kucaklarına alıp seviyorlardı. Ellerimize ve ayaklarımıza iğneler batırıp canımızı da acıtırıyorlardı. Ara sıra gelip bizi severken ağlayan ve endişeli bir şekilde bize bakan kişilerin anne ve babamız olduğunu tahmin ediyordum. Kız kardeşim kırk günlükken eve gitti. Ne olduğunu anlayamıyordum. Beyaz önlüklü amcalar ve teyzeler sürekli başımda toplanıp konuşuyorlardı.

Sanırım benim biraz daha kuvözde kalmam gerekiyordu. Bu kişilerin yüzlerinde hep kaygı ve merak ifadesi vardı. Tam 68 gün olmuştu, anneler gününden bir gün önceydi, annem gelip artık beni almak istediğini söyledi. Beyaz önlüklüler kabul etmediler, annem ısrar edince babama bir kağıt imzalattılar. O kağıtta yazan neydi bilmem ama babamı bir hayli korkutmuştu. Ve sonunda evimize geldik. Kız kardeşim çoktan odamıza almıştı. Beni görünce çok sevindi. Annem çok mutluydu, anneler gününde çocuklarının ikisi de yanındaydı. Babam ona çok güzel bir çiçek getirmişti. Ancak telaşları bitmemişti. Bizim odamıza herkes giremiyordu, bana ve kardeşime sürekli ilaçlar veriliyordu. Anlaşılan halen iyileşmemiştik.

Tüm bunları yaşarken insanların ağızlarının hareketini izliyordum, ama sanırım kardeşim ve diğer insanlar benden farklı olarak bu ağız hareketleri dışında aralarında bir şeyler paylaşıyorlardı. Annemin bana endişeli bakışları bitmedi. Onu tam anlayamadığımı, seslendiğinde bakmadığımı, ağlarken bana ninni söylediğinde sakinleşmediğimi düşünmeye başladım. Duyma-

duğımdan şüphelenmişti. Bunu anlamak için beni götürdükleri yerde kulaklarım ve başıma bir şeyler taktılar. Uyumuşum, uyandığımda annem ağlıyordu. İşte o gün öğrenmişti, ben duymuyordum. Canım annem, ne de çok üzülp ağlamıştı. Babam ise ona sarılıyor, sanırım üzülmemesini söylüyordu. Ama annemden habersiz bizim başımıza gelip o da ağlıyordu. Anlayamıyordum, ben mutluydum, niye bu kadar üzülmüyorlardı, sorun neydi? Duymamak ne demek bilmiyordum ama her şeyi izliyor ve anlıyordum. Yaşamak benim için çok güzeldi. Keşke anneme anlatabilseydim. Aslında bakışlarımla ve gülücüklerimle isteklerimi ve onu ne kadar sevdiğimi anlatabildiğimi düşünüyordum. Sonra kulaklarım “işitme cihazı” dedikleri birer alet taktılar. Hiçbir şey değişmemişti. Ben yine duymuyordum. Aradan 1 yıl geçti, beyaz önlüklüler benim kulaklarımı yine incelediler, filimler çektiler ve “koklear implant” diye bir şey önerdiler. Annem ve babamın yüzlerinden anladığım bu uygulama zor bir şeydi. Annem yine ağladı.

Bir aile ile tanıştık, çocukları koklear implant kullanıyordu. Bize başka ülkeden bir merkezin adresini verdiler. Babam orasıyla yazıştı, onlar da bize dersler yolladılar. Ne çalışkandı babam. Bilgisayardan aldığı dersleri çalışıyor ve benimle sürekli oynuyordu. 16 aylık olmuştum, annem beni kreş diye tanımladıkları bir yere götürdü. Ne çok arkadaş vardı orada. Çok sevmiştim burasını. Arkadaşlarımı takip etmekte zorlandım biraz, ama oyun oynamak için duymak ve konuşmak çok da gerekli değildi benim için. 17 aylık olunca annem ve babamla yine hastaneye gittik, artık beyaz önlüklülerin hemşire ve doktor olduğunu biliyordum. Bu sefer doktorlar soğuk bir odada uyuttular beni. Kafamın içine koklear implant denen bu aletin iç parçasını taktılar. Annem, babam, dayım, amcam, anneannem ve daha birçok kişi kapıda 4 saate yakın beni beklediler. Çok uzunmuş bu ameliyat. Aslında çok da umutlu girilmemiş ameliyata, yani duyamayabilirmişim de! İlk müjdeyi Şengül teyze verdi: “Ameliyat çok başarı geçti, Mehmet’in cihazı çalıştı”. Sanırım annemle babamın en mutlu anlarından biriydi bu. Uyandığımda

kafamda koca beyaz bir bez sarılıydı. Canım acıyordu. Hastanede bir odada babaannem ve annem benimle kaldı. Babam da akşamları yanımıza uğradı. Doktorlar sürekli gelip gidip başımdaki bandı açtılar, kafama bir şeyler sürdüler, bana iğneler yaptılar. Çok ağlamıştım.



Şükür çıktık hastaneden ve yine evimdeydim. Ne sıcaktı evim, çok seviyordum odamı. Çok da seviliyordum. Anne-annem ve babaannem için hep ayrıcalıklı oldum. Dayım, halam, amcam, kuzenlerim ne çok akrabam vardı. Akrabalarımız ve annemle babamın arkadaşları onları hiç yalnız bırakmadılar. Sürekli bize gelip annemle babamla sohbet ettiler. Bir hafta sonra bandaj dedikleri beyaz bant çıktı kafamdan. Kurtulmuştum, ne zordu onunla uyumak. Aradan 1 ay geçti, tekrar hastaneye gittik. Annemle babam çok heyecanlıydı. Ayça teyze kulağıma bir alet taktı ve sonra bir gürültü. Sanırım "ses" dedikleri buydu. Aman Allahım! Bu ne farklı bir şeydi böyle. Çok korktum ve çok ağladım, hiç hoşlanmamıştım bu ses denen şeyden. Kulaklık diye tanımlanan bu aleti kulağımın arkasında tutmak da ayrı bir sorundu. Neler denedi annemle babam. Bazı resimlerimde gördüm, bant bile yapıştırmışlar kafama.

Yavaş yavaş alışmaya başlamıştım sese. 1 ayın sonunda artık kapı çalınca duyuyordum. Bu işten en çok babam memnundu. O gelince zile basıyor, ben de koşup onu karşılıyordum. Gözlerindeki mutluluğu bana coşku verirdi. Aradan 4 ay geçmişti, ilk kelimem "araba" oldu. Herkes meraklı ve heyecanlıydı. Artık adıma bakıyordum, telefona koşuyordum. Çok komiktiler, gelip arkamda davul çalıp duyup duymadığımı kontrol ediyorlardı. Aslında kulaklığım takıldığından itibaren bir uğultu, gürültü vardı kafamın içinde ama yavaş yavaş anlamlandırmaya başlamıştım bu sesleri. Giderek kelimelerim arttı ve 2,5 yaşına geldiğimde kısa kısa cümleler kurmaya başladım. Daha kolay öğrenmeye başlamıştım. Ne çok öğrenecek şey ve ne çok ses vardı çevremde. Kuşlar, insanlar, araba kornaları, televizyon vs. her yerden farklı farklı sesler geliyordu. Herkes ve her şeyi çok iyi takip edemiyordum ama kreşteki arkadaşlarımı, annemi babamı daha iyi anlıyordum artık. Çizgi filmleri daha iyi takip edebiliyor, bir şey istediğimde daha iyi anlatıyordum. Babam "bu çocuk ne kadar derin ve anlamlı bakıyor", annem "sanki arkasında da gözü var" derdi. Evet, önceden gözlerimle öğrenirdim her şeyi ama artık duyarak da öğrenmeye başlamıştım. Duymam arttıkça gözlerimdeki derinliğin azaldığını söylediler.

Giderek büyüdüm ve büyüdükçe duymam ve konuşmam artı ve nihayet 5 yaşında iken Ayça teyze kafama bağladığı o garip kabloların sonucunda bilgisayara baktı ve "artık yaşlıları kadar duyuyor" dedi.

Benim duymam ve konuşmam herkesi çok keyiflendirmişti. Çocolata (çikolata), obobüs (otobüs), madi (mavi), Eşok eşok (eşek... eşek), Çobabam (kocaman), Muşeşem (muhteşem) gibi bazı kelimeleri herhalde çok komik söylüyordum, sürekli tekrarlatıyorlardı bana.

Anasınıfına başlayacağım yıl annemle babam okul telaşına düştüler. Sınıf sayısı az olsun, biraz özel ilgilenilsin diye özel okullara başvurdular. Okullar beni "değerlendirme" dedikleri şeye tabi tuttular. Birkaç okul "bu çocuk biraz hareketli" ya da "sizden ayrılmada zorlanıyor" gibi enteresan bahanelerle bizi nazikçe reddetti. Aslında hareketliydim ama okula alınmamak için gerçek sebep bu muydu acaba? Bu arada söylemeyi unuttum. Benim annem de doktor. Ama önlük giymiyor. Uzun süre onun ne doktoru olduğu anlayamadım. Çocuklarla sohbet ediyor, oynuyor. Garip gelmişti bana. Sonunda anladım ki o çocukların bedenleri ile değil hareketleri, konuşmaları, davranışları ile ilgileniyordu. Neyse annem benim okula alınmama bayağı sinirlenmişti. Babam hep daha sabırlıydı ve okul sınavlarına beni o götürdü. Başvurduğumuz 3. okul beni "beğendi" ve kabul etti. Halen o okulda ve

2. sınıftayım. Çok fark edilen bir çocuktum. Kulağımdaki aksesuarımın yanı sıra kolay ilişki kurmam, hareketliliğim ve cana yakınlığım okulun tüm personeli tarafından tanınmamı sağlamıştı. Anasınıfı öğretmenlerim ve rehber öğretmenim bana çok yardımcı oldular, onlara minnettarım.

İlkokula başladığımda yeni bir heyecan bastı annemi. Öğretmenim anlayışlı olacak mıydı acaba? Onun beklentileri diğer velilerden farklıydı. Benim bir şeyler öğrenmemden çok, kabul edilmem ve uyum sağlamamla ilgileniyordu. Annem tez canlı ama çok çabalayan biridir. Durmadı hiç hep araştırdı, daha ne yapabiliriz diye? Bu araştırmaları sırasında tanıştığı biri laf arasında ona "...ilkokula kadar konuşursa" diye bir şey söylemiş. Çok uzun bir süre bunu kafasına takmıştı. Evet, konuşuyordum ama okuyup yazabilecek miydim? Hayatımda başıma gelebilecek en büyük nimetlerden biri ilkokul öğretmenimdi. Onu o kadar çok seviyorum ki! Annem babam kendini duygusal açıdan korumak için benimle ilgili beklentilerini düşük tutmuşlardı sanırım. Müge öğretmenim ise onlara benden çok şey beklediğini söyledi. Sınıfta en önde oturdum, öğretmenim benimle diğer çocuklardan daha çok ilgilendi, anlamadığımı tekrar etti. Bu arada başka bir öğretmen de bana okuma yazmayı öğrenene kadar özel ders verdi. Sonunda yaşitlarımla beraber okuma yazmayı öğrendim. Yazımı annem beğenmez, öğretmenim "çok karizmatik" derdi. Okumamı annem yavaş bulur, öğretmenim "harika okuyor" derdi.

Neden sadece benim kulaklık taktığımı merak etmeye başlamıştım artık. Bir gün gidip anneme "ben niye duymuyorum?" diye sorduğumda, annem erken doğduğum için kuvözde kaldığımı ve bu nedenle olmuş olabileceğini söyledi. Bir süre sonra babama "peki ben abi olunca da mı bu kulaklığı takacağım?" diye sordum. "Evet" dedi. Devam ettim, "baba olunca? dede olunca?" Hepsine cevabı "evet" oldu. "Ya ölünce?" dediğimde "bilmiyorum" dedi. Bir süre sonra "bu kulaklığı hep takacağım bunu anladım, ama öbür kulağımda niye yok, ona da takalım, o da duysun" dedim. Babam şaşırıldı. "Sen zaten duyuyorsun" dedi. Aradan birkaç ay geçti, bu soru kafamı meşgul ediyordu. Anneme sorumu tekrarladım. "Ameliyat olman gerekir" deyince korktum aslında, ama olmak istedim. Çok şaşırıldı ve zor bir ameliyat olduğunu söyledi. Sonrasında annemi ve babamı bir telaş aldı. Toplantılara katıldılar, sürekli okudular, uzmanlara danıştılar. Sonunda ikna oldular ve 1. sınıfın yarıyıl tatilinde diğer kulağıma da ameliyat ettirdiler. Sanırım ülkemizde böyle bir tecrübe çok yoktu. Yine Şengül teyze ameliyatıma girdi ve yine annemle babama güzel müjdeyi verdi. "Cihaz çalışıyor, ameliyat başarılı geçti". Ben iki kulağımda da koklear implant kullanan ilk çocuklardanım. Ayça teyzem de heyecanlıydı. Merakla bekledik. 1. ayın sonunda dış parça takıldı. Canım yine çok acıdı. Sesler kafama 'biiip' diye geliyordu. Bu "bip bip" sesleri de beni deli ediyordu. Hayal kırıklığıydı benim için, hemen duyacağım sanmıştım. Ama anladım ki biraz zaman gerekiyordu. Zaman içerisinde bu biip sesleri birleşip kelime oluyordu. Okuldaki arkadaşlarım beni 2 kulaklıkla görünce hem şaşırıldılar, hem de sevindiler. Onlar bana hep yardımcı oldular. Kulaklığımın pili bitince taktılar, derste geri kaldığımda anlattılar, kulaklığım kaybolduğunda buldular. Sonunda 1. yılın sonu geldi ve okuma bayramında arkadaşlarımın oylaması ile "yılın en gayretli öğrencisi" ödülü almıştım. Birinci sınıfın yazında annem peşimi bırakır mı hiç! Tatil falan dinlemedi, çalıştırdı beni. İkinci sınıfta öğretmenlerim çok uslandırdığımı söylediler. Önceki sene epey yormuşum onları belli ki.

2. sınıfın da sonuna gelmek üzereyiz. Derslerim iyi, İngilizce öğretmenim de beni çok başarılı buluyor. Teşekkür ederim Çağlar amca, Ayça ve Şengül teyze. Artık duyan, anlayan, öğrenen ve konuşabilen bir çocuğum. Farkım yok arkadaşlarımdan.



Uzm. Ody.
Rasim ŞAHİN

Koklear implant ↘ öncesi ailenin değerlendirilmesi

İşitme engelli çocukların dil gelişiminde ailenin rolü çok fazladır. Çünkü;

- Okul öncesi çocuklar zamanlarının çoğunu evde aileleriyle beraber geçirirler.
- Çocukla olan paylaşımlar ve deneyimler ailede çok fazladır. Bu da uzmanlar olarak çocuğu en iyi şekilde tanımaya olanak sağlar.
- Uzmanlar çocukla çok az zaman geçirirler.
- Ayrıca, çocuk yabancı kişi ve yerden çekingenlik duyabilir.
- Etkin müdahale ve sonuç, ebeveynin bilgili, becerikli ve çocuğu ile olan çalışma arzusuna bağlıdır.

“

Şu da unutulmamalıdır ki sosyoekonomik düzeyi nasıl olursa olsun ebeveynlerin, çocuklarının eğitimleri için, yeterli hale gelmeleri kendi bilgi, beceri ve arzularına bağlıdır.

”



Çocukları koklear implant kullanacak ailelerin değerlendirilmesi büyük önem taşımakla birlikte bu değerlendirme için henüz formal bir test bulunmamaktadır. Bu nedenle Koklear implant kararını verecek olan uzmanlar, ailenin eğitimini göz önünde tutarak, aşağıdaki soruların yanıtlarına dikkat etmektedir;

- Aile işitme kaybını ne zaman fark etti? (erken dönemde işitme kaybını fark eden ailelerin çocuklarına olan ilgilerinin daha iyi olduğu bilinmektedir.)
- İşitme kaybı teşhisi ne zaman kondu? (İşitme kaybını fark etme ve teşhis arasındaki zaman farkı ailenin ilgi ve dikkat seviyesini tekrar göstermektedir.)
- İşitme engelli çocuğun cihaz kullanımı ne zaman başladı?

Erken dönemde cihaz kullanımı, ailenin ilgi ve isteğinin yeterli düzeyde olduğunun önemli bir işaretidir.

- Kullanılan cihaz işitme kaybına uygun mu?
- Cihaz, devamlı ve etkin olarak kullanıldı mı?
- Eğitime ne zaman başlandı?
- Eğitimlere düzenli ve etkin bir şekilde katılım oldu mu?
- Eğitim önerileri uygulandı mı ya da uygulamak için çaba sarf edildi mi?
- Aile ve çocuk arasındaki ilişki olumlu mu?
- Aile işbirliği için açık mı? Sorunların çözümü için eğitmen ile çalışıyor mu?

Uzmanların bu sorulara aldığı yanıtların büyük kısmı olumluysa hasta rahatlıkla koklear implant ameliyatına yönlendirilebilir. Sonuç olarak;

- Ebeveyni yeteri ilgi, istek, beceri ve beklentiye sahip yaşı ve bilişsel becerileri yeteri düzeyde olan koklear implant adayları hiç vakit kaybetmeden implant edilmeli.
- Anne babası işitme engelli olan uygun koklear implant adaylarının işiten, yeteri ilgi, istek ve beceriye sahip birincil bakıcı ve uygun okul öncesi desteği sağlandığı süreçte koklear implant yapılmalı.
- Ek engeli olan koklear implant adaylarında karar; engelin türü, derecesi ve ailenin ilgi, istek, beceri ve beklentileri ile özel eğitim desteği dikkate alınarak verilmelidir.
- Ebeveynleri farklı dil kullanan uygun koklear implant adayları mutlaka implant edilmelidir.

Şu da unutulmamalıdır ki sosyoekonomik düzeyi nasıl olursa olsun ebeveynlerin, çocuklarının eğitimleri için, yeterli hale gelmeleri kendi bilgi, beceri ve arzularına bağlıdır.

Bu aileler uzman desteğiyle yeterli beceriye sahip olup çocuklarına her ortamda dil gelişimi için faydalı olabilmektedirler.

İşitme çözümlerinde
bir dünya lideri olan
Cochlear, 100'den fazla
ülkede 250.000'den fazla
kullanıcısını yeniden
hayata bağlıyor. 40 yılı aşkın
tecrübesiyle kullanıcılarına
daha iyi işitme çözümleri
geliştirmek için çalışıyor.

Bugün, geleceğiniz için bir sonraki adımı atın!

Cochlear Nucleus 5 Sistemine Geçiş

Nucleus 5 Sistemi her açıdan en iyi Cochlear Nucleus işitme çözümüdür. CP810 Ses İşlemcisi omni-directional iki mikrofonu sayesinde benzersiz bir işitme performansı sağlar. CR110 Remote Assistant seçeneğiyle de kablosuz olarak işitme düzeyini iyileştirmeyi, sorun gidermeyi ve ebeveynlerin, kullanıcı aktif yaşamına devam ederken Ses İşlemcisinin çalışıp çalışmadığından emin olabilmelerini sağlar.

Arka plan gürültüleri iki kat arttırıldığında bile Nucleus 5 Sistemi kullanıcılarının anlama seviyelerinde herhangi bir düşüş olmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bununla birlikte Nucleus 5 Sistemi SmartSound programları sayesinde her türlü ortamda daha iyi bir işitme sağlar.

Nucleus 5 Sisteminde telefon kullanımı olabildiğince doğaldır. Telefonunuza cevap vermek için kulağınıza yaklaştırmanız yeterlidir. CP810 Ses işlemcisi telefonu otomatik olarak algılar! Bunun dışında cihazınıza MP3 çalar, televizyon gibi birçok ses cihazını, aksesuarlar yardımıyla Ses İşlemcinize bağlayabilirsiniz. Dinamik FM dâhil Euro 3 pim tipi konektöre sahip FM alıcıları Nucleus 5 Sistemine sorunsuz ve güvenli bir biçimde bağlanabilir.

Değiştirilebilir kapaklarıyla Nucleus 5 Sistemini kolayca kişiselleştirebilirsiniz. Snugfit ve LiteWear seçenekleriyle bebeğinizin Nucleus 5 Sistemine adapte olmasını kolaylaştırabilirsiniz.

Şarj edilebilir bataryalarıyla çok daha küçük ve su geçirmez bir sistemin keyfini çıkarırsınız. Kilitlenebilen pil ünitesi sayesinde ses işlemcisini meraklı küçük ellerden koruyabilirsiniz.

En önemlisi; Nucleus 24 ve Nucleus Freedom İmplantı kullanıyorsanız ödüllü Cochlear Nucleus 5 Sistemi ile yeni bir ameliyata gerek duymadan en iyi işitme performansına sahip olabilirsiniz!

Cochlear Nucleus CP810 Ses İşlemcisi ve Cochlear Nucleus CR110 Remote Assistant, en iyi işitme potansiyelini gerçekleştirmek için, en son teknoloji ile sizin için tasarlandı.

Cochlear, Nucleus 5 Sistemi ile hayatınızı bir anda değiştiren günlere bir yenisini eklemek için sizi ofislerine davet ediyor!

Bir bakışta Nucleus 5

Cochlear Nucleus 5 Sistemi, işitme performansını eskisinden çok daha iyi bir düzeye getiren teknoloji ve tasarım geliştirmeleri içerir.

CP810 SES İŞLEMCIŞİ



- Dikkat çekmez; kulağınızda olduğunu bile unutabilirsiniz.
- Kullanımı kolaydır; şarjlı bataryaları sayesinde pil değiştirme sıkıntısı yaşamazsınız.
- Daha çok ses; Cochlear'ın Smart Sound adlı ses yükseltme teknolojisiyle daha çok ses duyarsınız.
- Daha rahat bir sohbet; 360° ses alabilen omni-directional, güçlü zoom yeteneğine sahip iki mikrofonu sayesinde gürültülü ortamlarda sesleri daha iyi algılayabilirsiniz.
- Islanmaktan korkmayın; şarjlı pillerle kullanıldığında suya dayanıklıdır, yağmurdan kaçmanıza gerek kalmaz.



CR110 REMOTE ASSISTANT*

- Kolay kullanım; tek ya da çift taraflı CP810 Ses İşlemcileriyle tek tuşla, dikkat çekmeden, kablosuz iletişim kurarsınız.
- Kablosuz; CR110 Remote Assistant'la CP810 Ses İşlemcileriyle iletişim kurmak için kabloya ihtiyaç duymazsınız.
- Dikkat çekmez; Ses işlemcisini kontrol etmek istediğinizde çocuğunuzun sözünü kesmek zorunda kalmazsınız.
- Tek tuş; Ses işlemcisinin ya da bobinin durumunu kontrol etmek için tek bir tuşa ihtiyaç duyarsınız; Cochlear Tuşu.

* CR110 Remote Assistant Nucleus 5 Sistemine ek olarak opsiyonel olarak sunulmaktadır.

özelliklerine sahiptir. Bu özelliğiyle de telefon kullanımı daha kolay ve eğlenceli oluyor.

- CP810 Ses İşlemcisi FM alanındaki en son teknolojiyi destekler. –Phonak Dinamik FM Sistemi.
- CP810 Ses İşlemcisi şarj edilebilir pilleriyle kullanıldığında sektörün en yüksek su koruma derecesine sahiptir. (IP57) Ter içinde kalana kadar spor yapabilir, çocuğunuzun bahçede suyla oynamasına izin verebilirsiniz. CP810 Ses İşlemcisi çalışmaya devam edecektir.
- CP810 Ses İşlemcisi bugüne kadar yapılmış en küçük ve en hafif ses işlemcisidir. Şık, ince ve gelişmiş bu işlemci göze çarpmayacak biçimde ergonomik olarak tasarlanmıştır.
- CR110 Remote Assistant ile Ses İşlemcisini dikkat çekmeden ve güvenli bir biçimde kontrol edebilirsiniz.

SGK, koklear implant kullanıcılarına geri ödeme avantajı sunuyor.

- 7 yıldan fazla süredir koklear implantı kullanıyorsanız,
- Kullanım ömrünü tamamlamış olan Sprint veya Esprit 24 Ses İşlemcilerinden birini kullanıyorsanız,
- Esprit 3G ya da Nucleus Freedom cihazınızda tamiri mümkün olmayan problemler varsa,
- Odyoloğunuzun tavsiyesi doğrultusunda çocuğunuzun işitsel gelişiminin Nucleus 5 Sistemi ile daha iyi olacağı raporlanmış ise,

Siz de Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödeme kapsamında olabilirsiniz. Nucleus 5 Sistemine geçişinizin 11.400 TL'lik kısmı SGK tarafından karşılanıyor! Geriye kalan katkı payınızı ise Bonus veya Worldçizlilikli kredi kartlarınızla, 6 taksitte, ödeyebilirsiniz!

Daha fazla bilgi edinmek için Cochlear ofisleriyle irtibata geçebilirsiniz.

Neden Nucleus 5'e geçiş yapmalıyım?

Nucleus 5 Sistemi, kullanıcılarına işitme performansında yeni bir kalite ölçütü sunuyor.

- Cihazlarını Nucleus 5'e yükselten kullanıcılar üzerinden elde edilen klinik sonuçlar, Nucleus 5 Sisteminin günlük yaşamda gerçek ve izlenebilir bir fark yarattığını ortaya koyuyor.
- CP810 Ses İşlemcisi sektördeki ilk ve tek otomatik telefon algılama

Şu anki ses işlemcinizi CP810 Ses İşlemcisi ile karşılaştırın.

ÖZELLİK	Sprint™	Esprit™	Esprit 3G	Freedom	CP810
Güçlü züm özelliğine sahip gelişmiş ikili mikrofön teknolojisi					✓
Cochlear'ın SmartSound adlı ses yükseltme teknolojisi				✓	✓
Telefon kullanımı: otomatik telefon bobini					✓
İki yönlü remote assistant					✓
Dinamik FM desteği					✓
Su geçirmezlik				✓***	✓*
Şarj edilebilir pil seçeneği	✓			✓	✓
Renkli kapak ve desenlerle kişiselleştirme			✓	✓	✓

* Şarj edilebilir pil modunda uluslararası IP57 standardı; zincir pil modunda IP44

Cochlear, yaşam boyu çözüm için yeni teknolojiler...

“

Doğadaki bütün sesleri duyuyor olmak çok hoşuma gitti.

”

24 yaşında genç bir mühendis adayı ve 8 yıldır Baha® kullanıyor. Yaştları gibi dolu dolu bir hayatı var; dans ediyor, Almanca konuşuyor hatta çokça seyahat edip yurt dışında bir iş deneyimi bile edinmiş. 8 yıldır Baha kullanan Zafer Kitay'la kendi hikâyesini konuştuk...

Bir an

kendimi kuş gibi hafif hissettim

Zafer Kitay

“Etrafımdaki sesleri duyarken onlardan bir enerji aldığımı hissettim.”



Bize biraz kendinizden ve işitme ile ilgili rahatsızlığınızdan bahseder misin?

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisiyim. İşitme problemim doğuştan geliyor yani doğuştan duymuyordum ben. Problem yapılan testler ile fark edilmiş ve cihaz kullanımına karar verilmiş. 6'ncı aydan sonra işitme cihazı kullanmaya başladım. 2004'den beri Baha ile duyuyorum. 1988–2004 arasındaki süreçte de farklı bir cihaz kullandım. Daha önce kullandığın cihaz nasıldı? Memnun muydun? Daha önce asmalı taç şeklinde bir işitme cihazı kullandım. Başka bir işitme cihazı deneyimim olmadığı için bir şikâyetim yoktu.

Baha ile tanışman nasıl oldu?

Önce doktorlardan duyduk ve uzun süre araştırdık. Bir test sürecimiz oldu zaten, bana ve beklentilerime uygun olup olmadığı test edildi. Test sonuçları da olumlu olunca kullanmaya karar verdim.

Peki, Baha'nın ameliyat ile takılacağını öğrendikten sonra korktun mu? Seni kimler ikna etti?

Açıkçası ameliyattan korkmuyorum artık. Zaten ameliyat deneyimi fazla olan biriyim. Bu yüzden ikna edilmeme de gerek kalmadı.

Madem korkmuyorsun, biraz da ameliyat sürecinden bahseder misin?

Ameliyat çok rahat geçti. Zaten lokal anestezi yapıldı ve sabah girdiğim hastaneden akşam ayrıldım. Ameliyat gibi iyileşme sürecim de kısa ve kolaydı. Kişiye göre değişiklik gösterir belki ama bende aşağı yukarı 2 haftalık

bir süreçte yaralar iyileşti. Sadece enfeksiyon kapmamak için biraz dikkat gerektiren bir süreç oldu benim için.

Peki, işlemci takılması ve ilk işitme deneyimin?

Burada, implantın kemikle kaynaşmasını beklediğimiz bir süreç vardı. 3 ay kadar bekledik ve sonra işlemci takıldı. İlk işittiğim an şunu fark ettim, Baha daha önce kullandığım cihaza göre çok iyiydi. Bir an kendimi kuş gibi hafif hissettim. Doğadaki bütün sesleri duyuyor olmak çok hoşuma gitti. Etrafımdaki sesleri duyarken onlardan bir enerji aldığımı hissettim.

Dışarıda kafana iliştirilmiş bir metal parçanın olması rahatsız ediyor mu seni?

Bu tabi yaşa bağlı olarak değişir muhtemelen. Bayansanız cihaz saçlarınızın arasında kaybolur, rahatsızlık oluşturmaz. Aslında dışlerinize tel takarsanız o da metal, ona da alışıyorsunuz zaten. Dışardan gözükmemesi beni rahatsız etmedi. Şuan saçlarım uzun olduğu için fark edilmiyor da.

Peki, bakımı ile ilgili sorun yaşıyor musun?

Bakımı ile alakalı bir sorun yaşamıyorum. Zaman zaman o bölgede doku yenilenmesi sebebiyle kabuklanma oluyor, bu da olmazsa olmaz, sadece baştan bilmek gerek. Zaten banyo sırasında da kendi keline dökülüyor.



“Eğitim okulda başlar, evde biter” düşüncesinden uzak bir kurum *Özel Antalya Melekler Özel Eğitim Okulu...*



Deneyimli Kadro...

Antalya’da 2003 yılında kurulan Özel Yağmur Adam Özel Eğitim Okulu, 01.06.2011 tarihinden bu yana Melekler Özel Eğitim Okulu olarak eğitim hayatına devam etmektedir. Kurumun bünyesinde işitme engeli, yaygın gelişimsel bozukluk, hafif düzeyde mental retardasyon tanısı alan bireyler öğrenci olabilmektedir.

Kurum Anadolu Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü İşitme Engelliler Öğretmenliği mezunu olan kurucu Yağmur Ecem Su ile Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü mezunu olan müdür Günay Uğurlu, branş öğretmenleri, psikolog ve sekreteryadan oluşan 20 kişilik ekibi ile 150 çocuğa hizmet veriyor.

Özel Antalya Melekler Özel Eğitim Okulu, uzman eğitim kadrosuyla, toplumdan farklı özellikler taşıyan çocuk ve yetişkinlerin, sosyal ortamlarda kendini ifade edebilme ve ihtiyaçlarını doğru analiz edip bireysel olarak karşılayabilme becerilerini kazanmanın yanı sıra toplumla kaynaşarak iş birliği kurabilmelerini hedeflemektedir. Ayrıca tüm kurum personelinin alanında yetkin kişilerden oluşması, eğitim ve psikolojik destek çalışmalarının tamamlanmasında güncel akademik literatürün takibini kolaylaştırmaktadır. Bu sayede ailelerin ve öğrencilerin okula başvurdıkları andan itibaren sosyal hayat faaliyetleri, akademik beceri düzeyleri titizlikle takip edilmektedir.



“

Kurum “Eğitim okulda başlar, evde biter” düşüncesinden uzak durarak aile içi tüm iletişim becerilerini, aksaklıklarını, doğru ve yanlış davranış örüntülerinin detaylı tespitini ve yetersiz bulunan alanların telafisini oldukça önemsemektedir.

”



Psikolojik destek...

Kurum “Eğitim okulda başlar, evde biter” düşüncesinden uzak durarak aile içi tüm iletişim becerilerini, aksaklıklarını, doğru ve yanlış davranış örüntülerinin detaylı tespitini ve yetersiz bulunan alanların telafisini oldukça önemsemektedir. Bu sebeple birey hayatının aile, okul, arkadaşlar ve pek çoğundan oluşan bir “Sistem” olduğunun farkında olarak kurum bünyesinde uzman bir psikolog da bulundurmaktadır.

Öğrencilerin ve ebeveynlerin psikolojik süreçlerinin düzenli randevular ile takibinin yapılması; kurum- veli işbirliğini arttırması dolayısıyla, var olan risklerin ön görülmesine, gerekli yönlendirmeler aracılığıyla engellenebilmesine ve tanı-tedavi basamağında etkinliğin artmasına imkan tanımakta.

Sosyal hayatta da yanlarında

Kurum, toplumun etiketleyerek atıl konuma ittiği öğrencilerinin sosyal yaşamda da “HEPİMİZ” kadar rol alabilmesini ve hayata tutunmalarına teşvik etmek adına sürekli etkinlikler düzenliyor.



Cochlear™ Avrupa Başkanı Türkiye'deydi

Türkiye'deki kullanıcılarına Cochlear işitme teknolojilerini daha hızlı ve kaliteli bir şekilde ulaştırmak için 2008 yılında Türkiye ofisini hizmete sokan Cochlear, 3 yıl içerisinde servis ağını 3 şehirde 4 hizmet noktasına çıkarttı. Firma, Türkiye'ye geldiği günden bu yana yatırımlarını ve Türk KBB Hekimleri ile iş birliğini arttırmaya devam ediyor. Son olarak, Cochlear Avrupa Başkanı Richard Brook Türkiye'ye gelerek 5 farklı ilde alanın önde gelen isimlerinden 30'un üzerinde KBB hekimi ile buluştu.

Cochlear firmasının gelecek vizyonunu ve dünyadaki en son teknolojik gelişmeleri Türk hekimleri ile paylaşan Richard Brook, bir haftalık toplantı programı içinde Türkiye'nin farklı renkleri ve lezzetlerini tanıma fırsatı buldu.



Konya İşitme Rehabilitasyon Merkezleri Eğitim Toplantısı ilgi ile karşılandı

Konya Dedeman Hotel'de Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen işitme rehabilitasyon merkezleri eğitim toplantısı eğitimciler tarafından büyük ilgi gördü. Üstün Değişim Rehabilitasyon Merkezi'nden Ali Arnas ve Diltem

Rehabilitasyon Merkezinden Mustafa Topal'ın katkıları ile Cochlear Firması tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu, Doç. Dr. Esra Yücel ve İşitme ve konuşma terapisti Banu Ergünel işitme kaybı ve teşhisi, işitsel gelişim ve rehabilitasyon, lisan gelişimi ve konuşma bozuklukları konularında eğitimler verdiler.

Antalya'da koklear implantlı aileler ile buluştuk

Cochlear olarak, Antalya Akdeniz Toroslar kolejinde Nisan ayı içerisinde gerçekleştiren koklear implant aile bilgilendirme toplantısında Koklear implant kullanıcı ve aileleri ile tanışma ve sorularına yanıt verebilme şansı yakaladık. Kepez işitme engelliler okulu müdürü Niyazi Arşın'ın ve Melekler Rehabilitasyon Merkezinden Yağmur Ecem Su'nun katkıları ile gerçekleştirilen toplantıya Antalya ve çevresinde ikamet eden koklear implant kullanıcıları ve aileleri katıldı. Toplantıda işitme kaybına yaklaşım, rehabilitasyon desteğine ailelerin katılımı ve işitme engelli çocuklara yaklaşım konularında bilgiler verildi. Kullanıcıların cihaz bakımına ilişkin sorularının da Cochlear Müşteri hizmetleri yetkilileri tarafından yanıtladığı toplantı büyük ilgi ile karşılandı. Toplantıya Hacettepe Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gonca Sennaroğlu, Doç. Dr. Esra Yücel ve İşitme ve konuşma terapisti Banu Ergünel da konuşmacı olarak katıldı.





İzmir 9 Eylül Üniversitesi işitme engelli çocukların ailelerini bilgilendirme toplantısı

Dokuz Eylül Üniversitesi 26 Mayıs 2012 tarihinde "işitme engelli çocukların aileleri için bilgilendirme" toplantısına ev sahipliği yaptı. İED'nin (işitme engelliler ve aileleri derneği) Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliğiyle ile düzenlediği toplantıda "İşitme engelli ailelerin sorunları", "İşitme engelli çocuklarda işitme cihazı ve koklear implantla ilişkili sorunlar ve çözüm önerileri" konularında Prof. Dr. Bülent Şerbetçioğlu ve Doç. Dr. Günay Kırkım tarafından bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca tüm implant firmalarının yetkilileri kullanıcılarının cihaz ile sorularını yanıtladı ve çözüm önerilerini paylaştı.



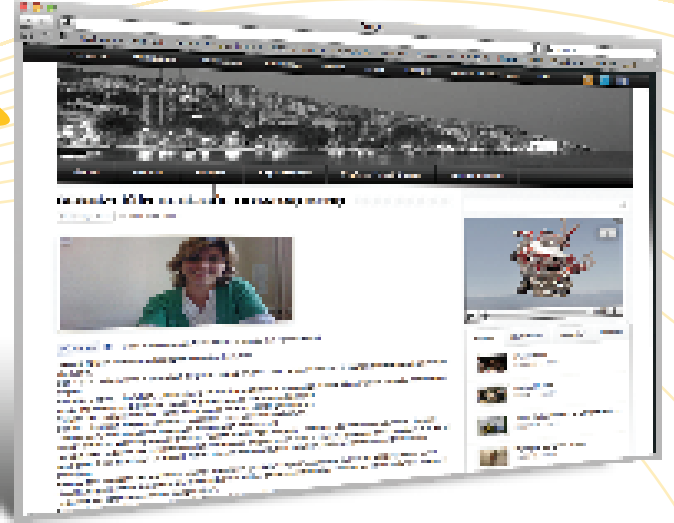
Kocaeli Üniversitesi'nde Baha® Bilgilendirme toplantısı

Kocaeli Üniversitesinde Mart ayında gerçekleştirilen Baha® bilgilendirme toplantısına Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi ve Kocaeli bölgesinin uzman doktor ve odyologları katıldı. Toplantıda Baha ürün uzmanı Uğur Tur kemiğe implante işitme çözümleri ve hasta seçimlerinde dikkat edilecek unsurlar ile ilgili bilgiler verdi. Bunun yanında Baha Ortadoğu iş geliştirme müdürü Roland Hilger Baha® işitme çözümlerinin geleceği konulu bir sunum ile yakında çıkması planlanan yeni kemik iletimli çözümler ile ilgili gelişmeleri Kocaeli bölgesi hekimleri ile paylaştı.

Sessizliğin sesi, Gül Ustabaş Genç

Gül Hanım 1973 doğumlu ve 8 yaşından beri işitme kayıplı. Kendisi aktif blog yazılarıyla işitme engellilerin ve koklear implant kullanıcılarının sorunlarını herkesle paylaşıyor. Birçok takipçisi olan siteye farklı yazılarıyla renk katıyor Gül Hanım. Yazmadaki amacını da "Engellilerinde toplumda bir birey olduğuna dikkat çekerek, onların sorunlarına, bakış açılarına, sevinç ve üzüntülerine tercüman olmak" olarak nitelendiriyor. Gül Hanım'a, işitme sorunu yaşayan birçok insana örnek olduğu için biz de teşekkür ediyoruz.

<http://nilguncabaci.com/2012/01/sessizligin-sesi-gul-ustabas-genc/>



Sessizsiniz takımı

Bu site "aktivist işitme engelliler" tarafından oluşturulmuş "Sessizsiniz!" facebook grubundaki tartışmaların, fikirlerin, yorumların MANİFESTO olarak derli toplu olarak toplandığı ve işitme engelli aktivistlerin tanıtıldığı sitedir. İşte tam olarak böyle tanınıyorlar sitelerini. Sitede işitme engelli ile ilgili haberler, yararlı linkler ve işitme engelli hakları ile ilgili bilgiler bulunuyor. Siz de siteye üye olarak bu faydalı gruba katılabilirsiniz.

<http://manifestomuz.wordpress.com/>



Dumanı üstünde bir hayat

Delfina Hanım, 1974 doğumlu ve 16 yaşında bir çocuk sahibi. 2005 yılından beri de bu blogdan hayatı paylaşıyor tüm sevdikleriyle ve diğer işitme kayıplı insanlarla. Sitede işitme kayıplı çocuk sahibi olmaktan, işitme kayıplılarda meslek seçimine kadar birçok konuda yazılar bulmak mümkün. Samimiyetle paylaşılan bu yazıları okudukça sizler de kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

<http://isitmekaybi.blogspot.com/>



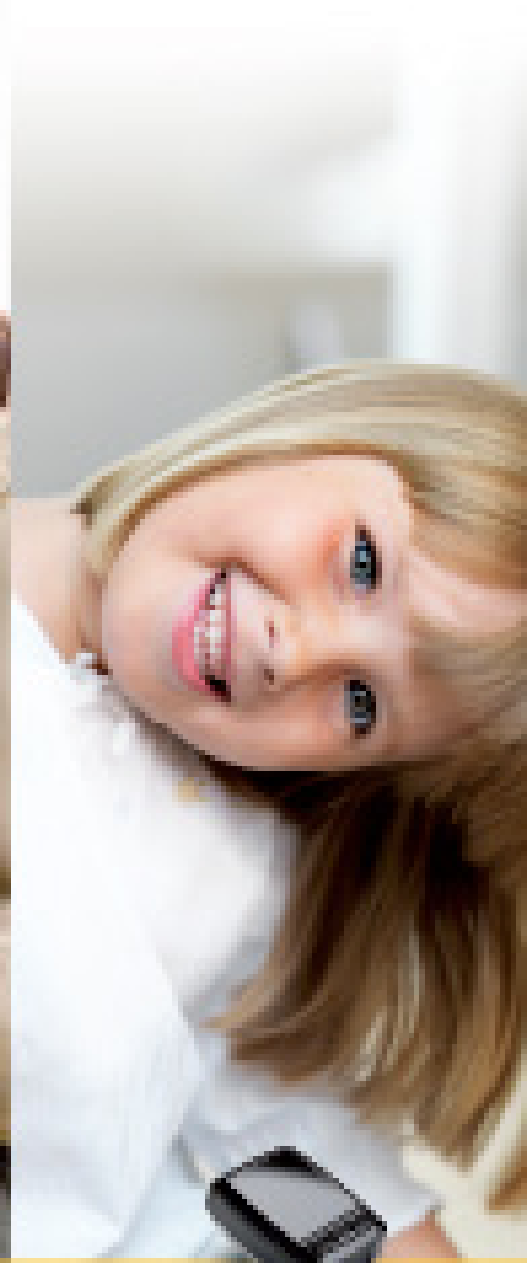
Sizin kadar benzersiz bir iřitme çözüümü



Cochlear Nuclia 5



Cochlear Hybrid



Cochlear Baha 6 BPH6

208.000'den fazla insan işitme cihazları, akıllı telefonları ve bilgisayarları bağlamak için Cochlear'a güveniyor. Bu insanların her biri, kendi gereksinimlerini karşılamak için Cochlear işitme çözümleri kullanıyor.

Cochlear'ın dünyadaki en güvenilir cihazları ve işitme çözümlerini sunar. 30 yılı aşkın kurumsallaşmış bir teknoloji bakımına sahiptir. İnsanlar hayatları boyunca en iyi işitme performansına sahip olmak için bize güveniyor.

Cochlear, hiçbir işitme çözümü sunmaz.

İnsanları birleştiririz - Dünyayı lideri - Virüsleri yitiririz - Yaşam için çözümler

Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin.
www.cochlear.com.tr

Hydrex, Cochlear and the stylized logo are trademarks of Cochlear Limited.
Nuclia is a registered trademark of Cochlear Limited. Baha is a registered
trademark of Cochlear Limited. Android, Android 4.4, ANDROID 5.0, ANDROID

Her new. And always.


Cochlear

Cochlear™ Baha® 3 Sistemi Aksesuarlar

Cochlear™ Baha® 3 Sistemi
Aksesuarları ile müziğin keyfini
en iyi şekilde çıkartın.

Tüm dünyada 80.000'den fazla
insan tarafından kullanılmaktadır.

İnsanları birleştirir • Dünya lideri • Vizyon sahibi • Yaşam boyu çözümler

Daha fazla bilgi için 0800 861 71 81 ücretsiz danışma hattını arayınız.
www.cochlear.com.tr